

皮膚がんの早期発見：診断力を磨くには？

名古屋市立大学大学院
加齢・環境皮膚科学
加藤裕史

slido

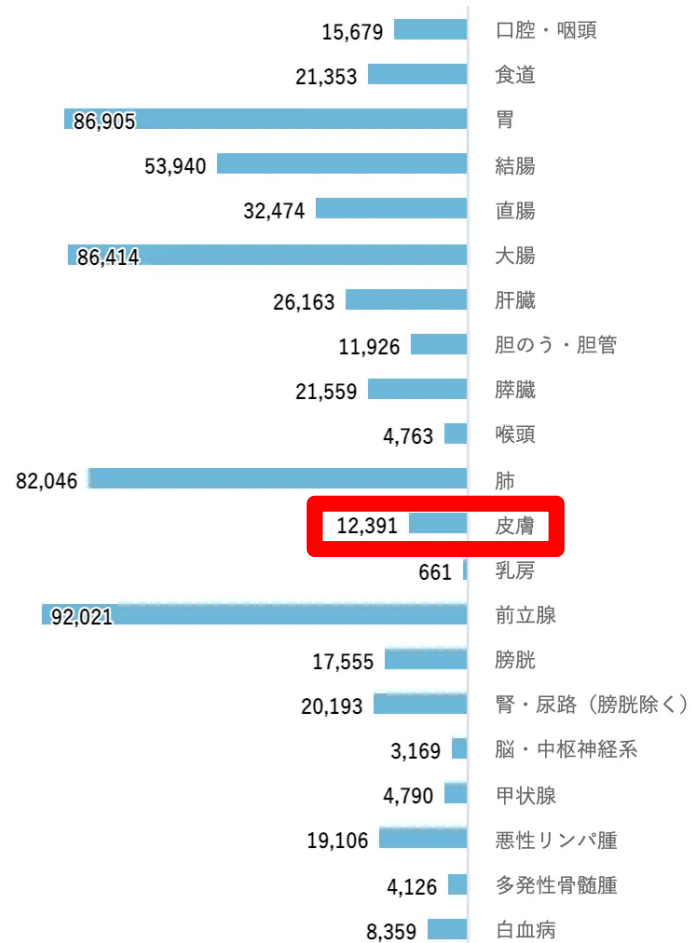
Join at
slido.com
#4194 791



PHILIPS

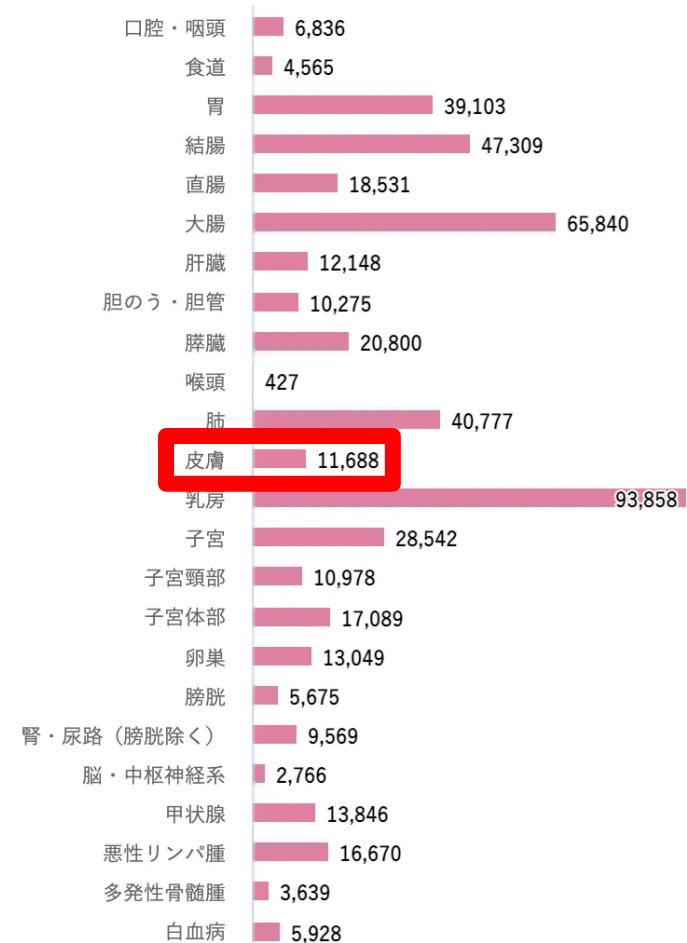
がんの罹患率

部位別がん罹患数
【男性 2018年】



(例)

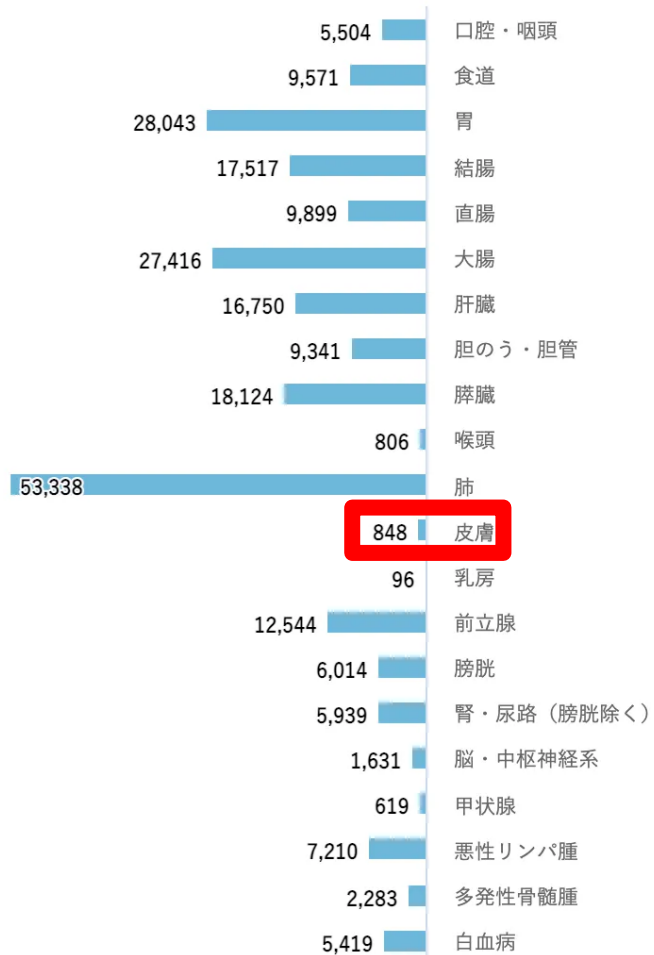
部位別がん罹患数
【女性 2018年】



(例)

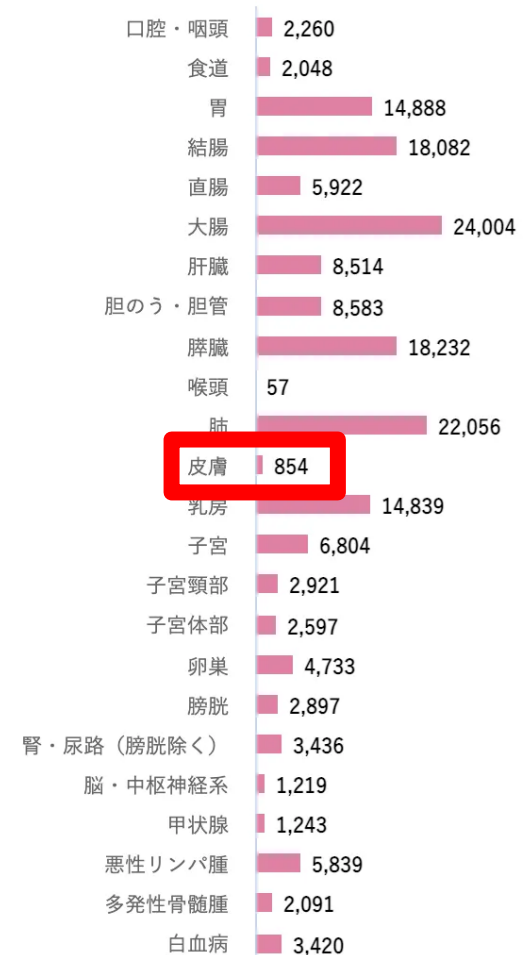
がんの死亡率

部位別がん死亡数
【男性 2019年】



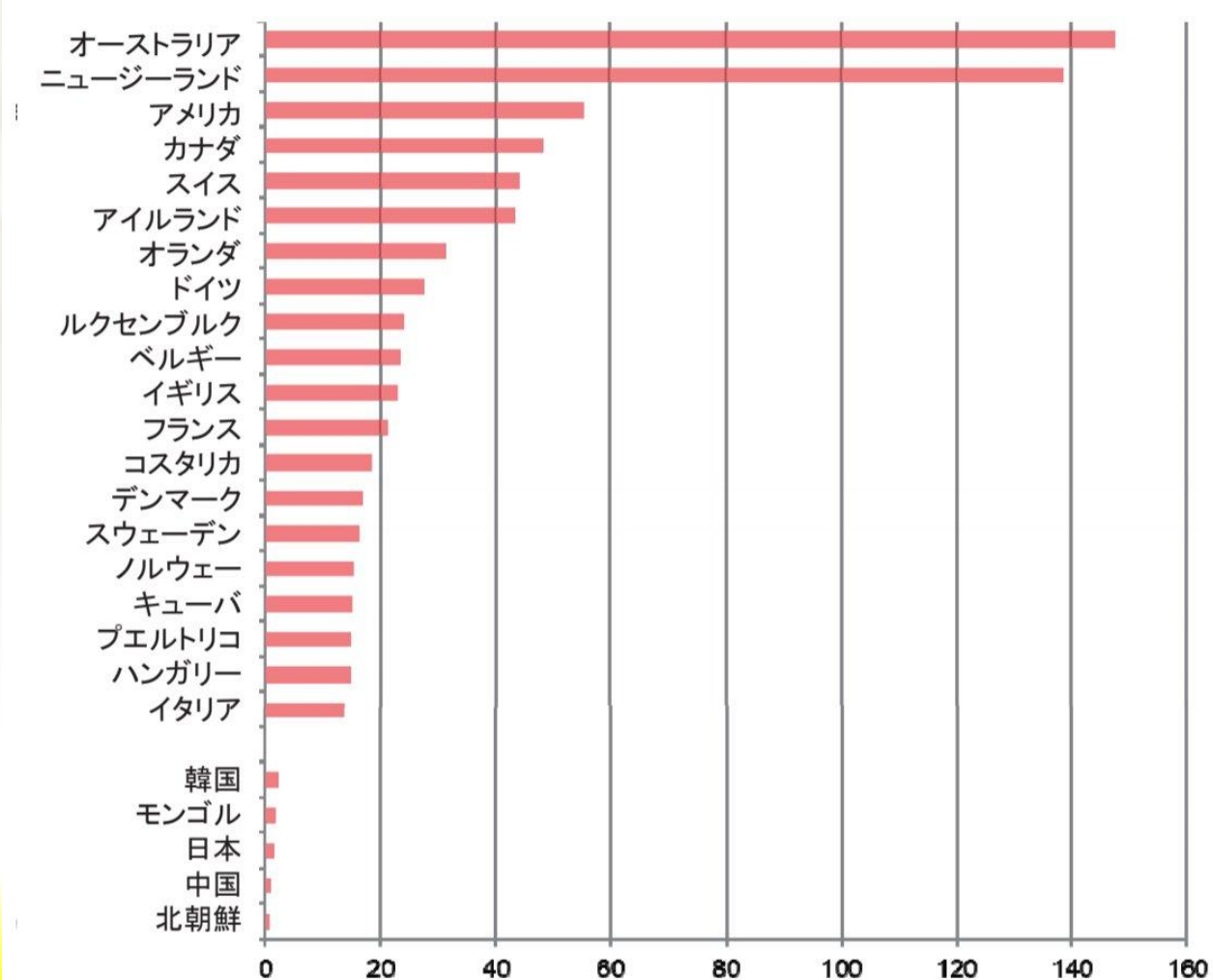
(人)

部位別がん死亡数
【女性 2019年】



(人)

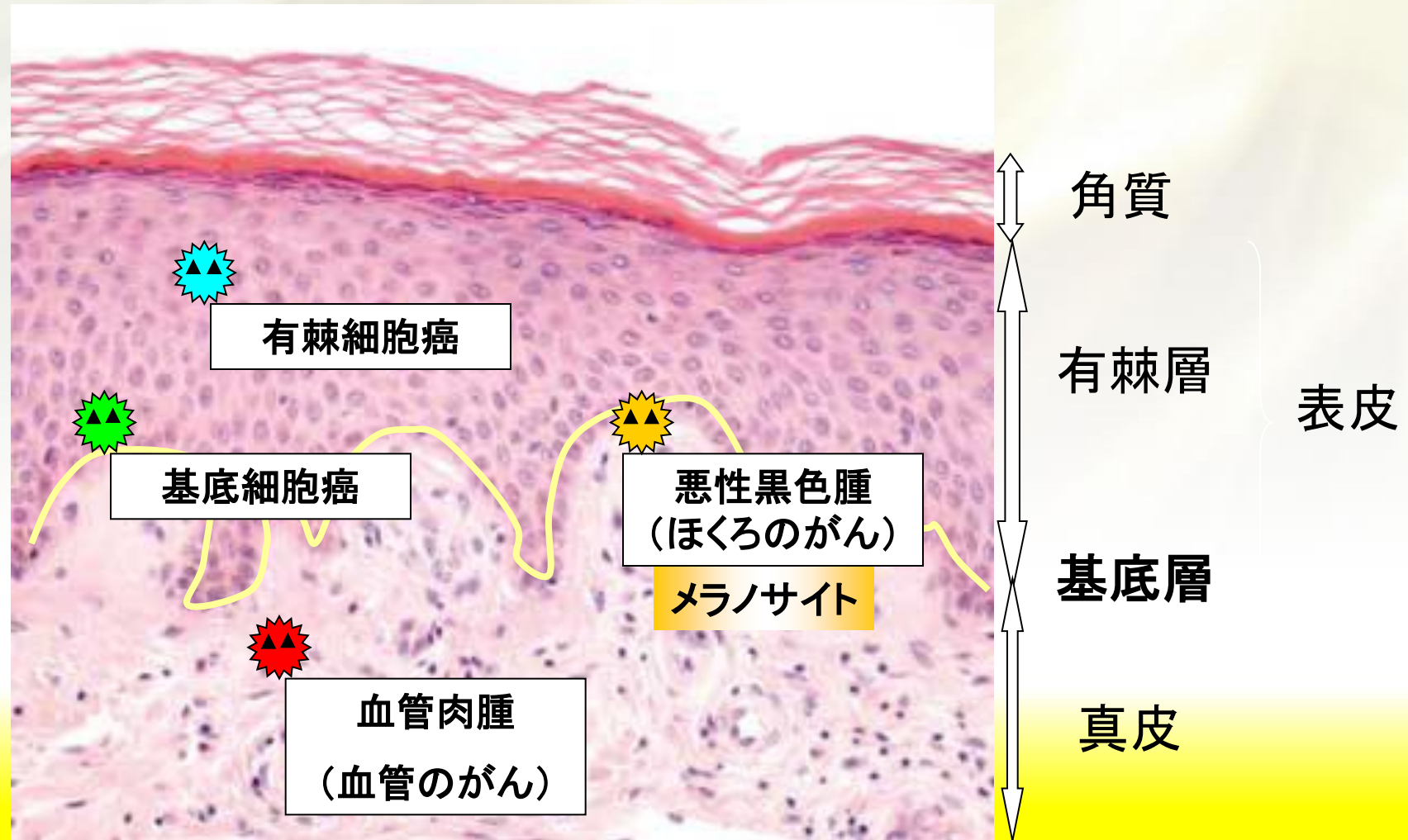
海外では



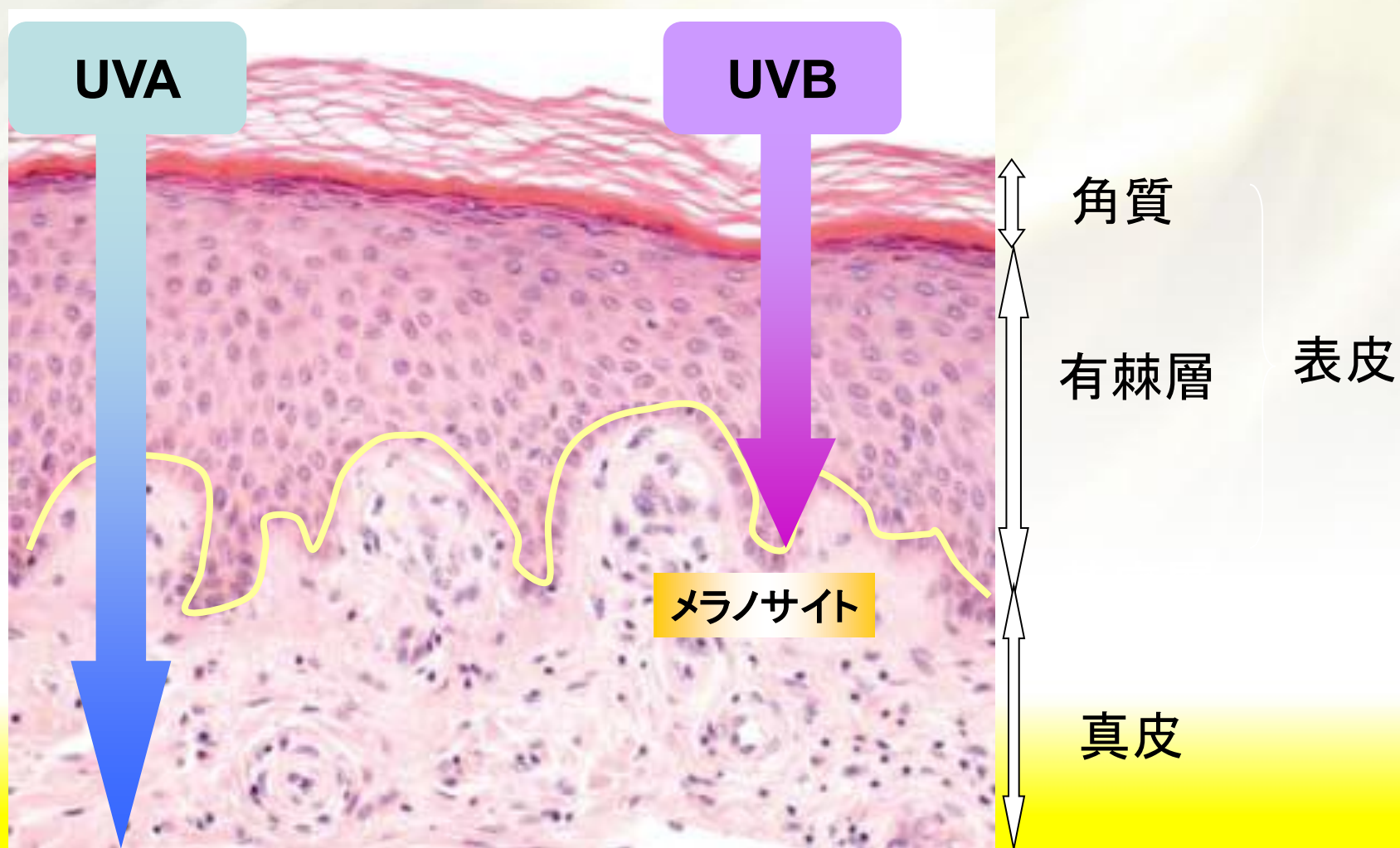
(／人口10万人)：出典IARC

<図2-3 2018年の上位20か国+東アジアの年齢調整罹患率>

皮膚がんの種類



皮膚がんの原因＝紫外線



どちらが「がん」かわかりますか？



惡性黑色腫

惡性黑子黑色腫



表在拡大型黑色腫



結節型黑色腫



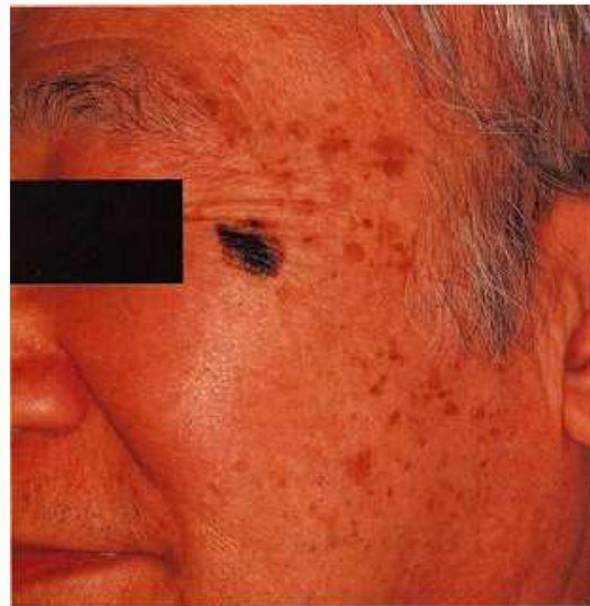
末端黑子型黑色腫



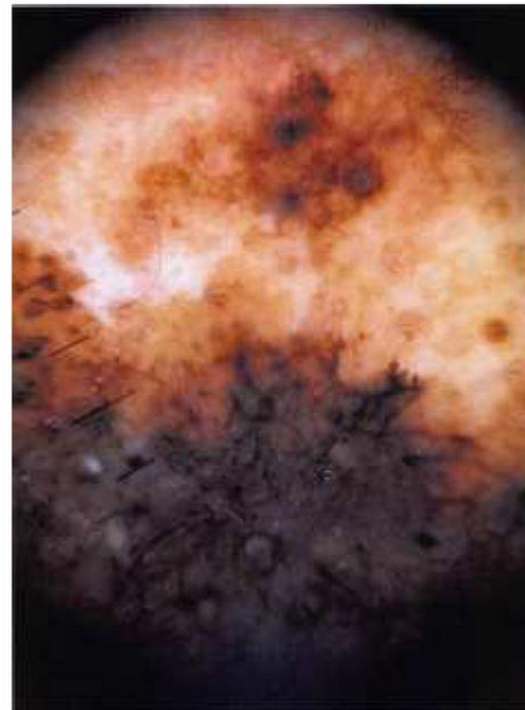
69歳の男性。顔面の皮疹を主訴に来院した。以前より顔面のしみが多かったが、3か月前からその一部の色が濃くなり、拡大してきたという。顔面の写真（A）と黒色斑のダーモスコピー像（B）とを別に示す。

この患者について正しいのはどれか。

- a 放射線治療が有効である。
- b 液体窒素療法が有効である。
- c 病変の深達度が予後に影響する。
- d ヒトパピローマウイルス〈HPV〉が発症に関与する。
- e センチネルリンパ節生検が診断のために必要である。



(A)



(B)

メラノーマってどんな検査をするの？

- ダーモスコピー
- 転移検索

画像検査・・・CT、PET-CT、MRI

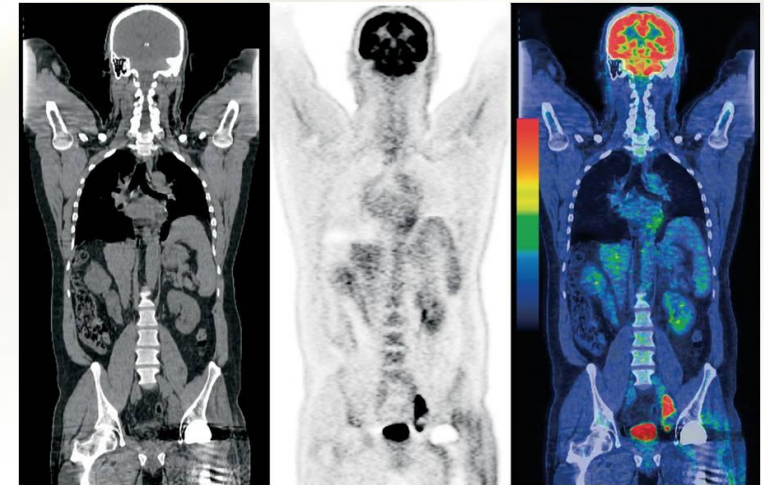
腫瘍マーカー・・・5-SCD(保険適用外)

- 遺伝子検査

BRAF遺伝子変異

PD-L1

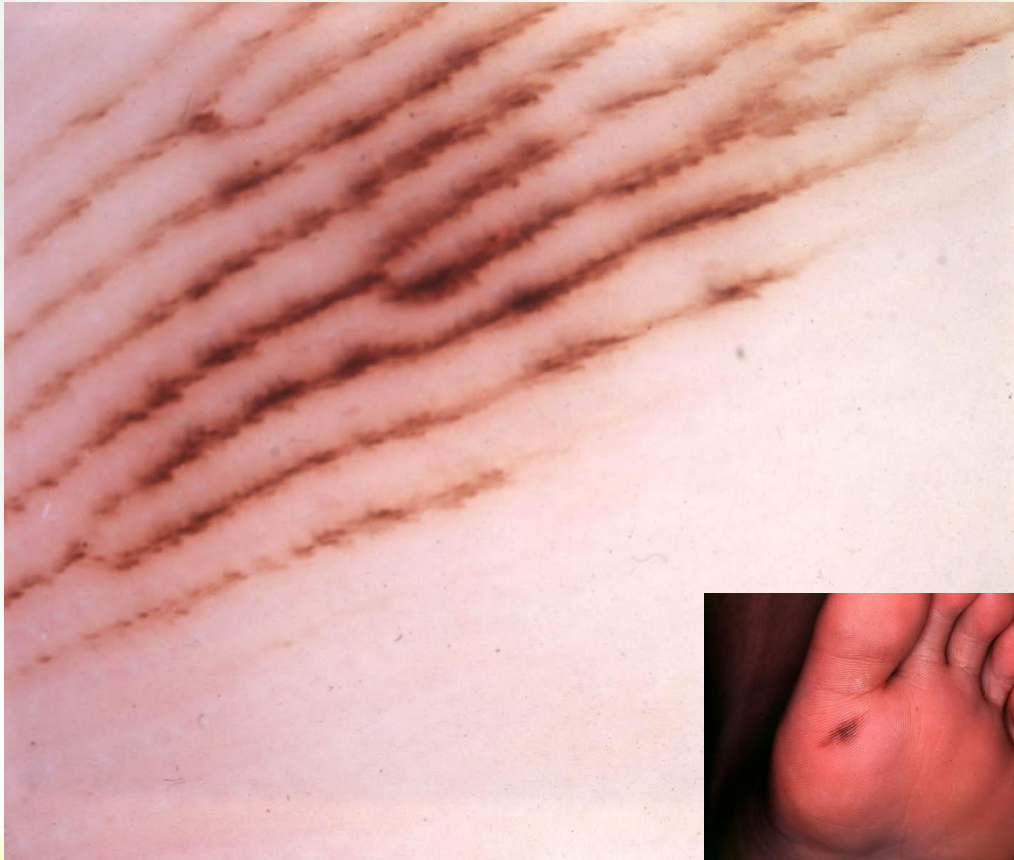
がんゲノム検査



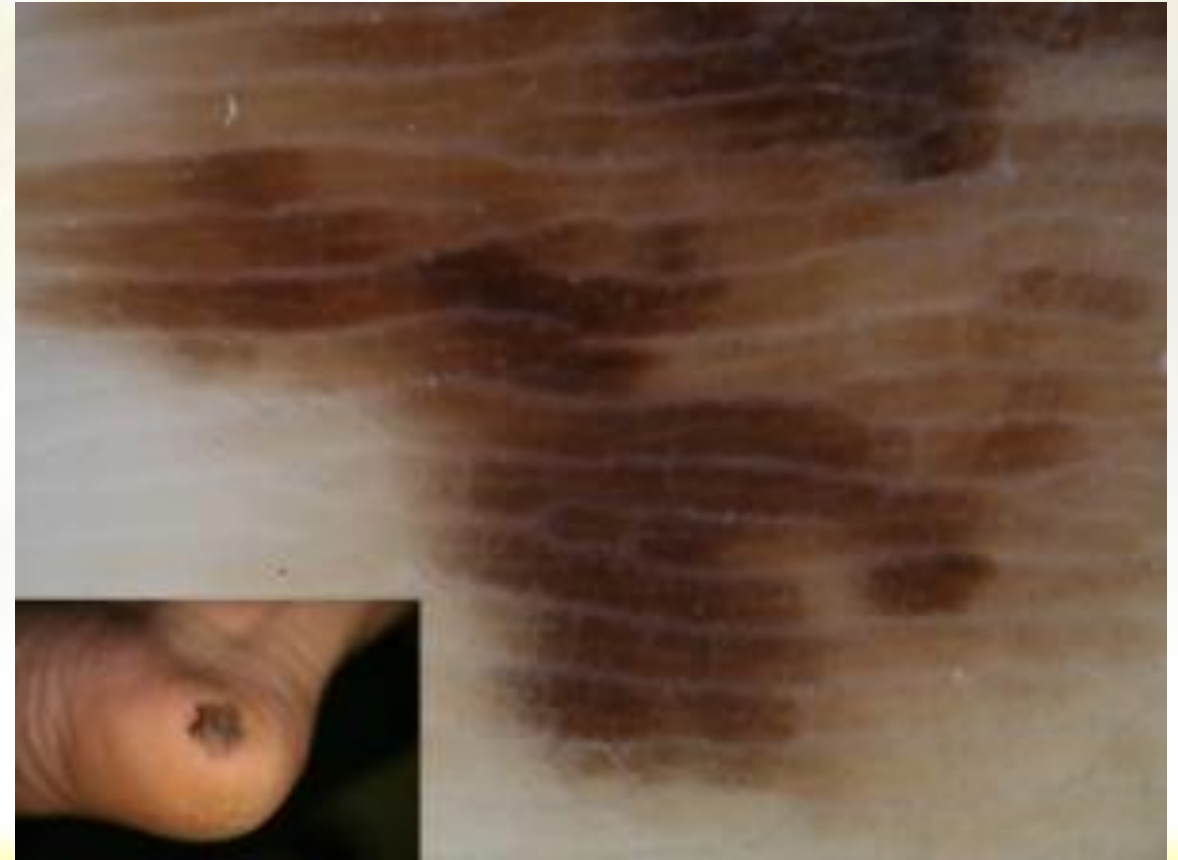
ダーモスコピー



まず覚えておきたいダーモスコピー像

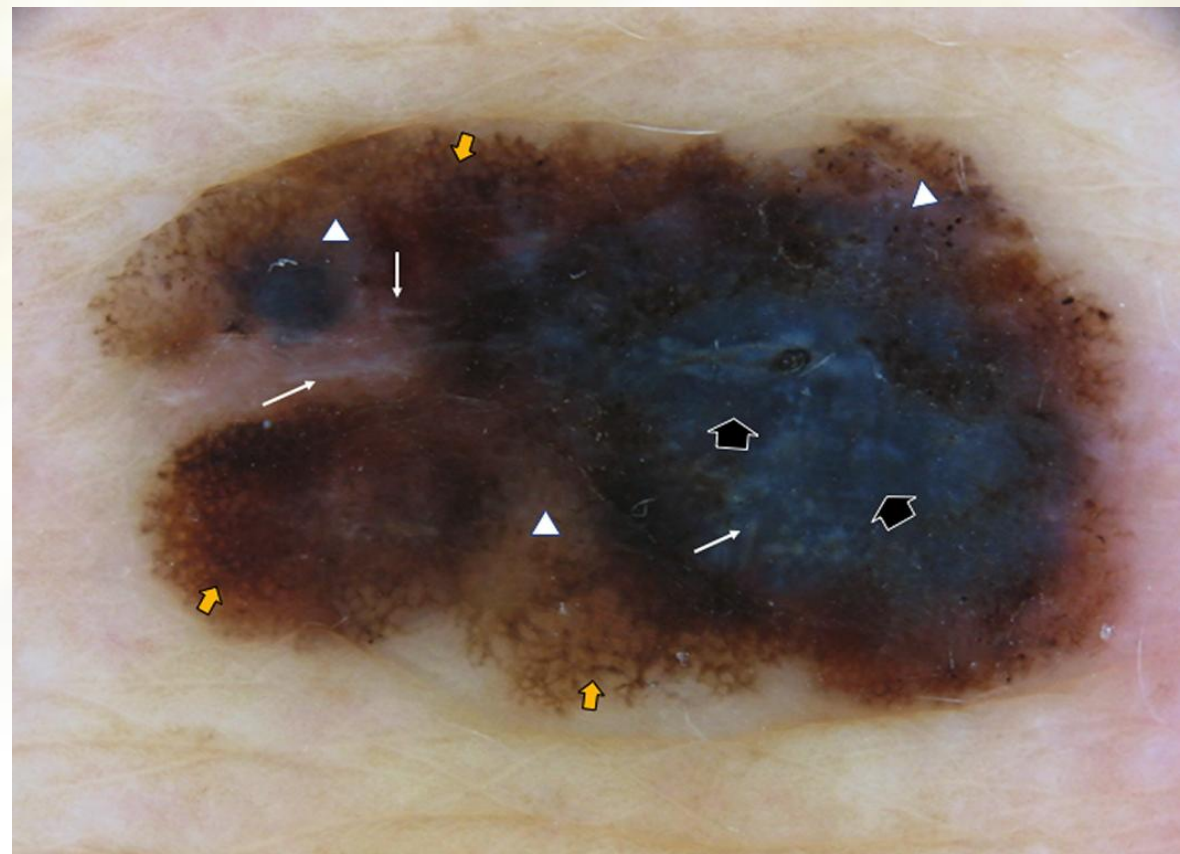


Parallel furrow pattern
皮溝優位パターン



Parallel ridge pattern
皮丘優位パターン

まず覚えておきたいダーモスコピー像



Blue whitish veil

20 36歳の女性。右上腕の皮疹を主訴に来院した。約10年前から右上腕に長径3 mmほどで平坦な皮疹が出現した。約3か月前から次第に拡大し隆起してきた。2週間前から出血するようになった。右上腕に18×16 mmの褐色結節を認める。右腋窩に径1 cmのリンパ節1つを触知する。右上腕の写真(別冊No. 4A)とダーモスコピー像(別冊No. 4B)を別に示す。

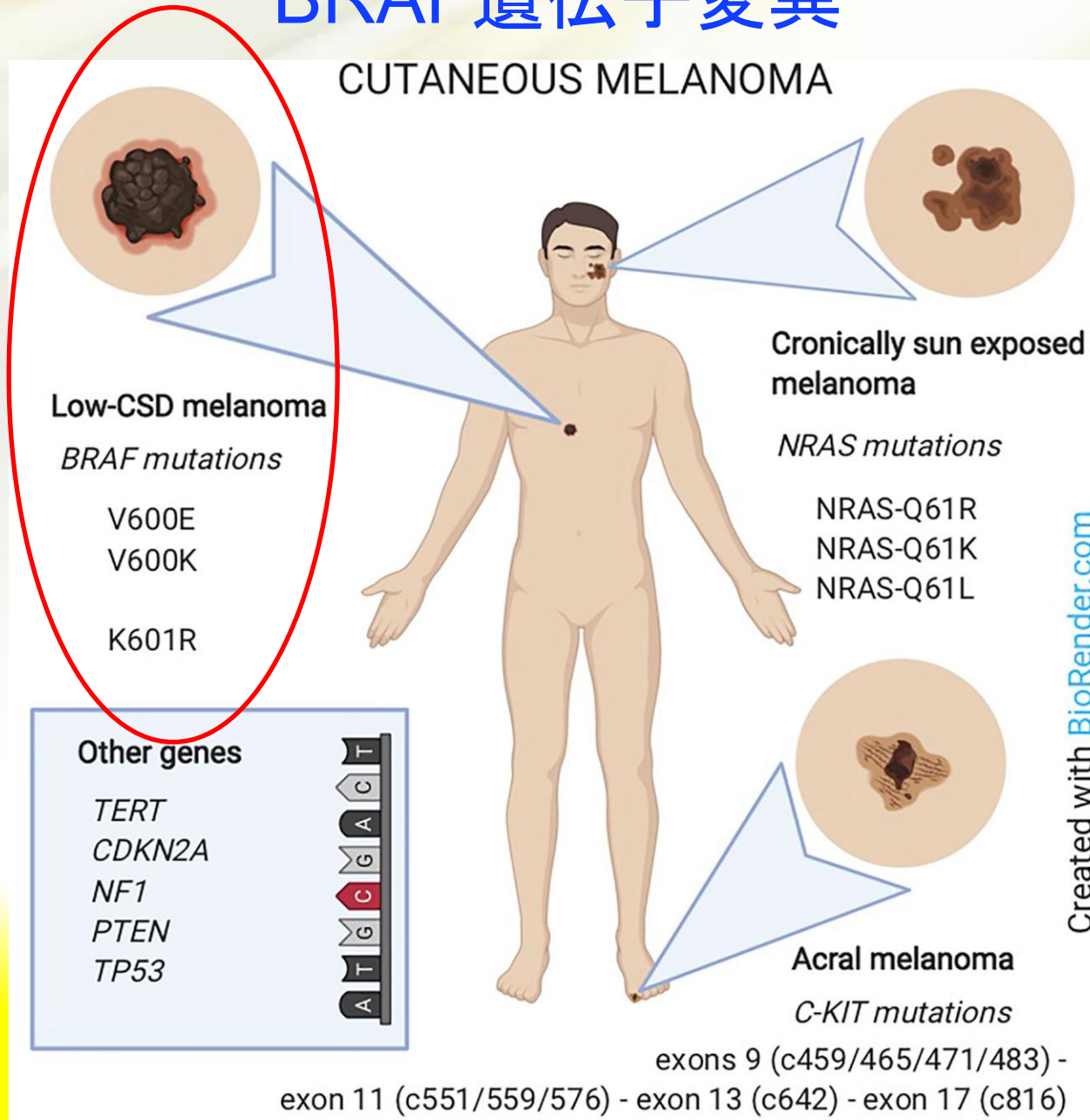
診断はどれか。

- a Bowen 病
- b 悪性黒色腫
- c 色素性母斑
- d 日光角化症
- e 脂漏性角化症

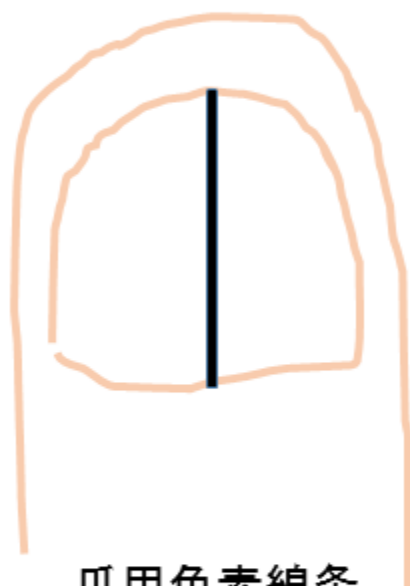


BRAF遺伝子変異

CUTANEOUS MELANOMA



爪に黒い線ができた時、あるいは黒い丸い点ができた時に
疑うべき病気とその特徴的な見た目



爪甲色素線条

10歳未満なら
経過観察
40歳以上なら
皮膚科へ



メラノーマ疑い

何歳であってもこれなら
大至急、皮膚科
40歳以上ならほぼ悪性



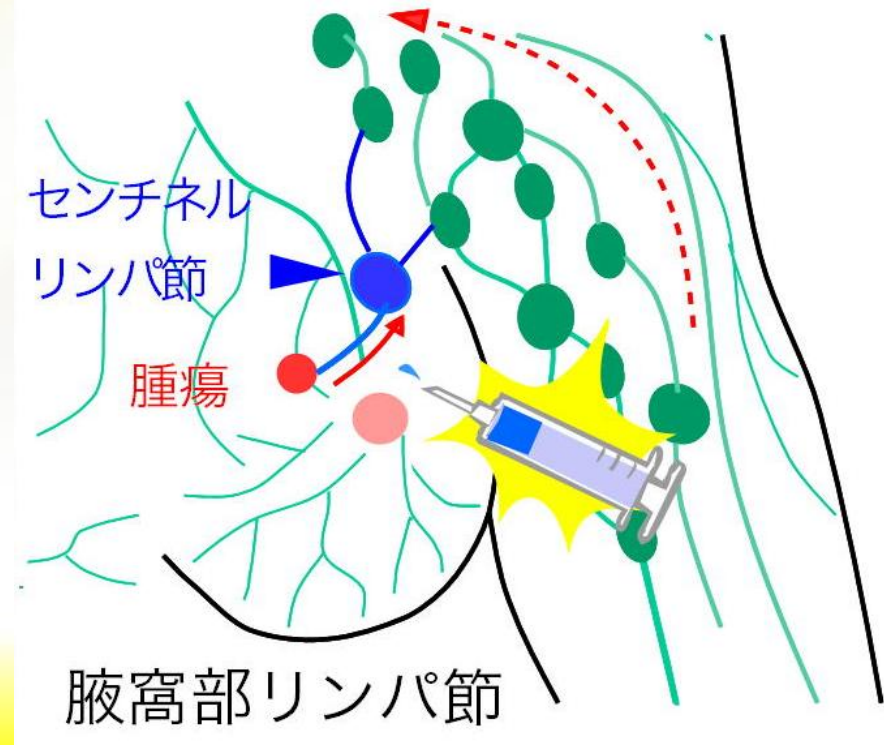
出血斑

外傷に思い当たれば
経過観察でOK
記憶になれば皮膚科

センチネルリンパ節生検



RI法と色素法を用いて一番最初に転移を起こすであろうリンパ節を同定して1-2個のリンパ節を生検する。



悪性黒色腫に対する薬物療法

【免疫チェックポイント阻害薬】

オプジーボ®(ニボルマブ)・・・抗PD-1阻害薬

キイトルーダ®(ペンブロリズマブ)・・・抗PD-1阻害薬

ヤーボイ®(イピリムマブ)・・・抗CTLA-4阻害薬

オプジーボ®＋ヤーボイ®(併用療法)

【分子標的治療薬】

タフィンラー®(ダブラフェニブ)＋メキニスト®(トラメチニブ)・・・BRAF＋MEK阻害薬

ビラフトビ®(エンコラフェニブ)＋メクトビ®(ビニメチニブ)
・・・BRAF＋MEK阻害薬

ゼルボラフ®(ベムラフェニブ)・・・BRAF阻害薬

CQ7. メラノーマの原発巣に部分生検 (incisional biopsy) を行ってもよいか

推奨度：C1

推奨文：全切除生検が困難な大きな病変では部分生検を行ってもよい。

解説：メラノーマ原発巣について、全切除生検 (excisional biopsy) すると単純縫縮が不可能な大型病変の場合や、顔面や手掌・足底などの病変で単純縫縮が難しい場合などに、診断と tumor thickness 確定のため、部分生検を選択してよいか否かが問題になる。従来部分生検によりメラノーマ細胞が深部に押し込まれて、局所再発、リンパ節転移や遠隔転移の危険性が高まると考えられてきた。

Pflugfelder らによる 9 編のシステマティック・レビューのうち、7 編（総症例数 5,017 例，全切除生検群 3,629 例，部分生検群 1,365 例）において全切除生検群と部分生検群間に局所再発率，生存率に差はなかった¹⁾。一方頭頸部原発症例を検討した後ろ向き症例対象

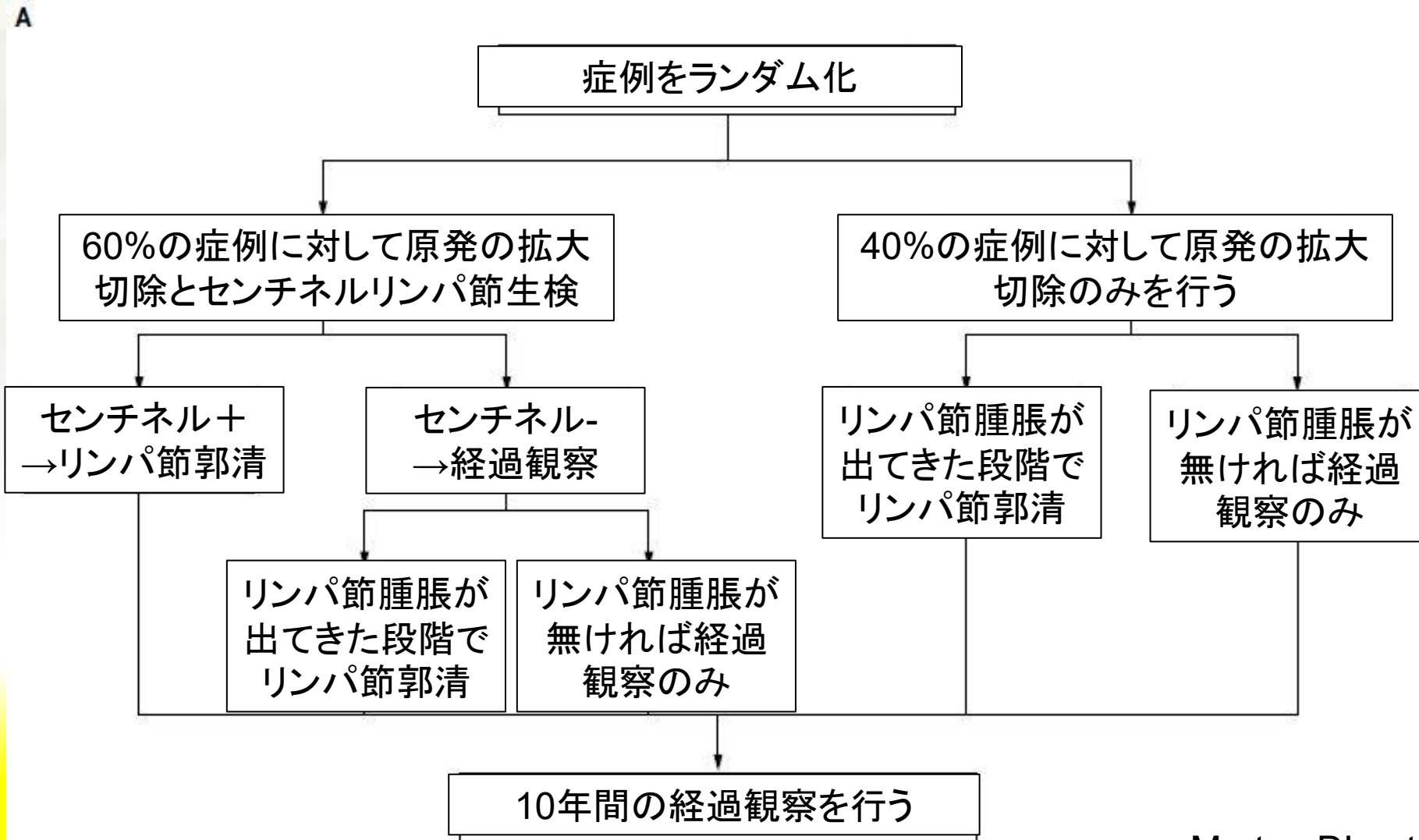
メラノーマに対する皮膚生検

悪性黒色腫について正しいのはどれか。

- a 放射線感受性が高い。
- b 日本人では結節型が多い。
- c 部分生検によって診断する。
- d TNM 病期分類の pT は原発巣の大きさを判定する。
- e センチネルリンパ節生検はリンパ節郭清の適応決定に有用である。

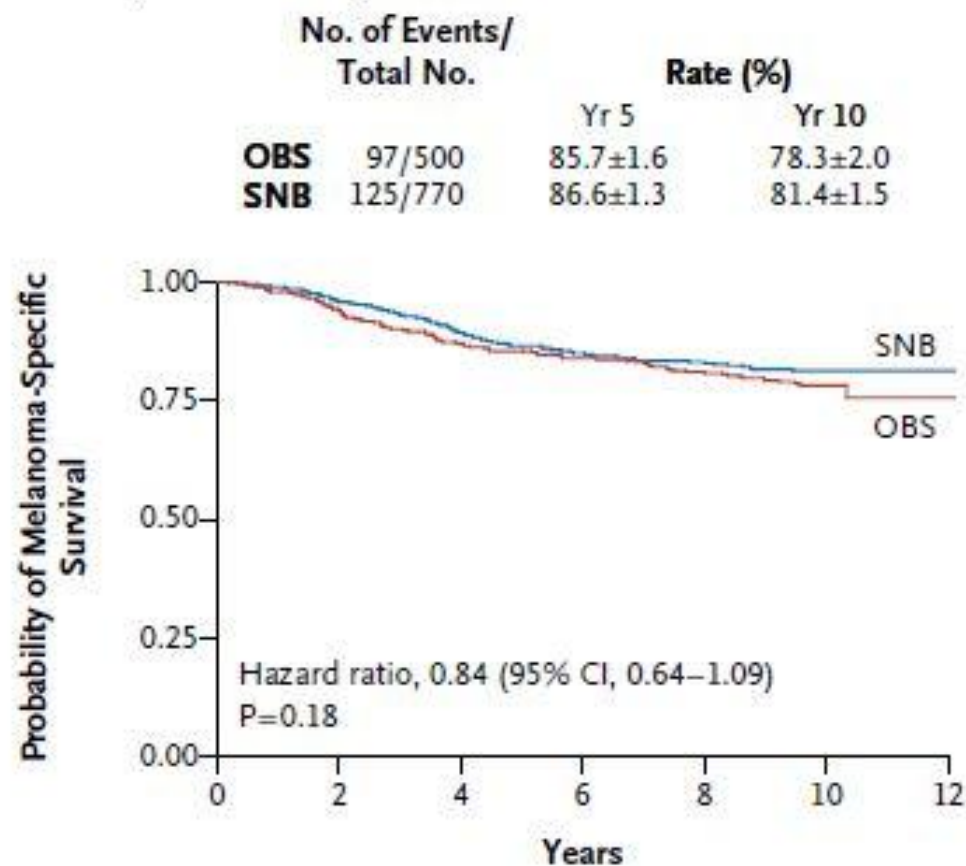


The Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial; MSLT-1



The Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial; MSLT-1

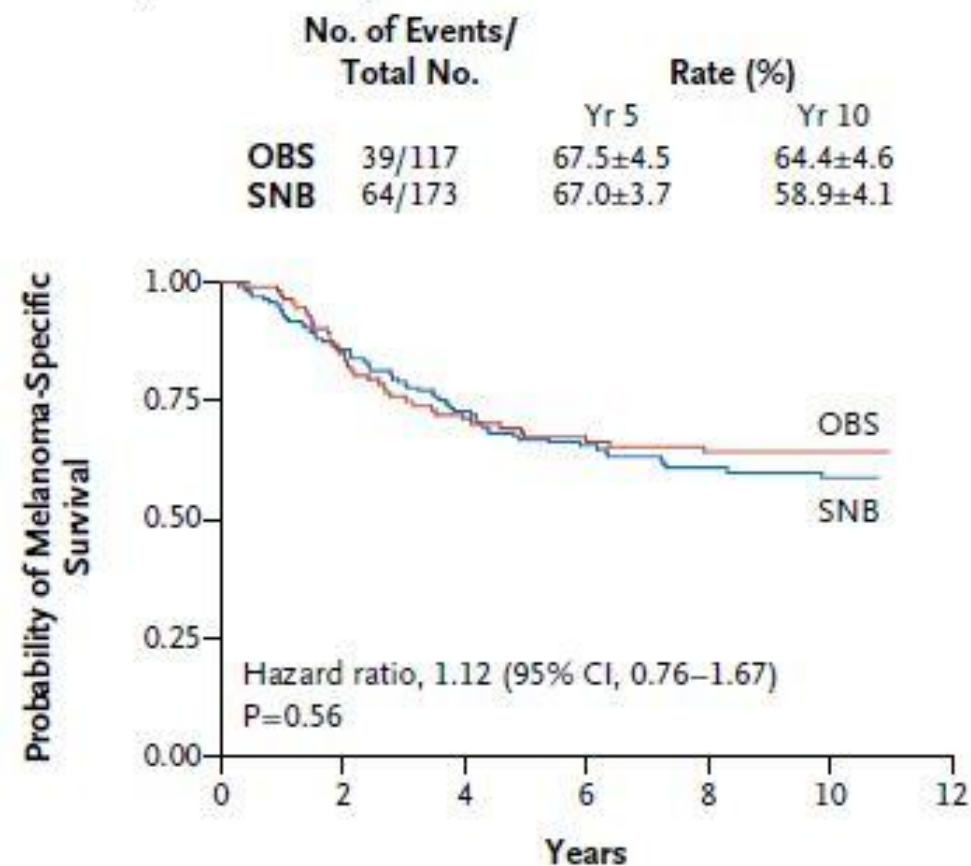
A Melanoma-Specific Survival, Intermediate-Thickness Melanomas



No. at Risk

OBS	500	448	390	351	318	191	4
SNB	770	700	611	530	467	282	5

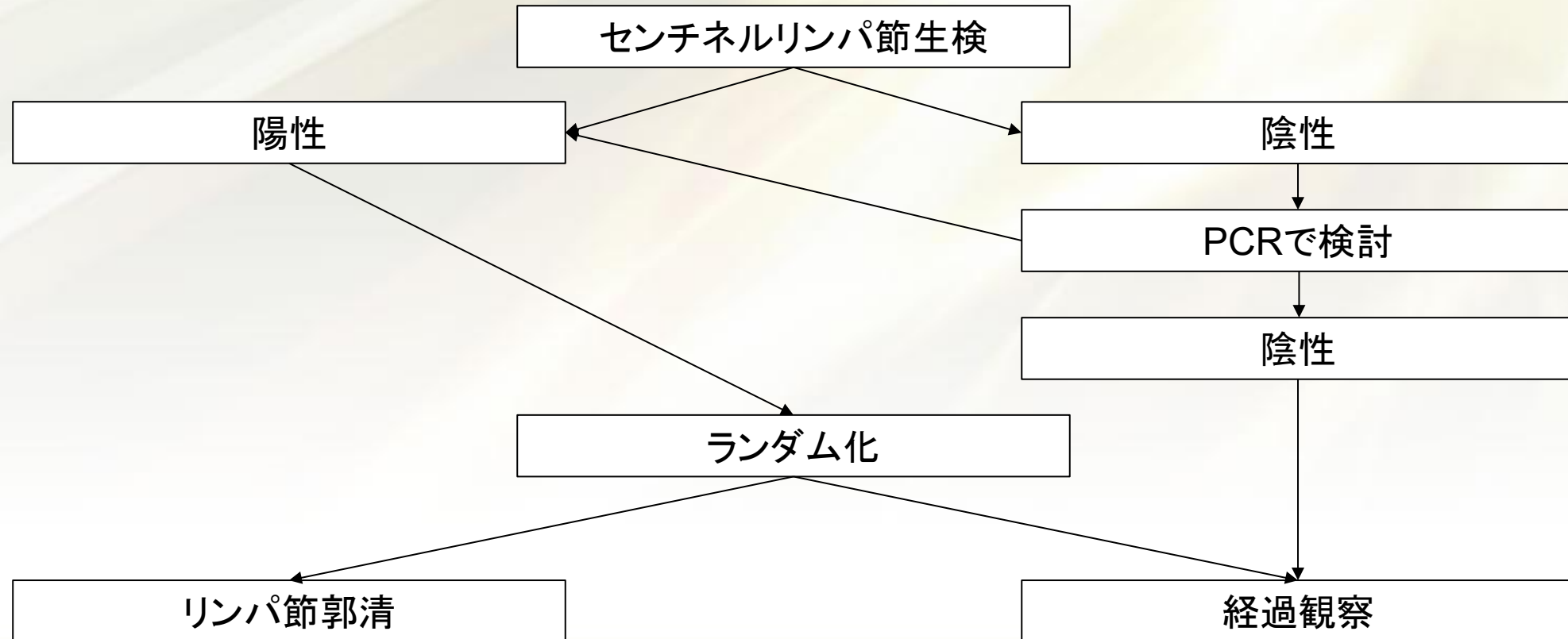
B Melanoma-Specific Survival, Thick Melanomas



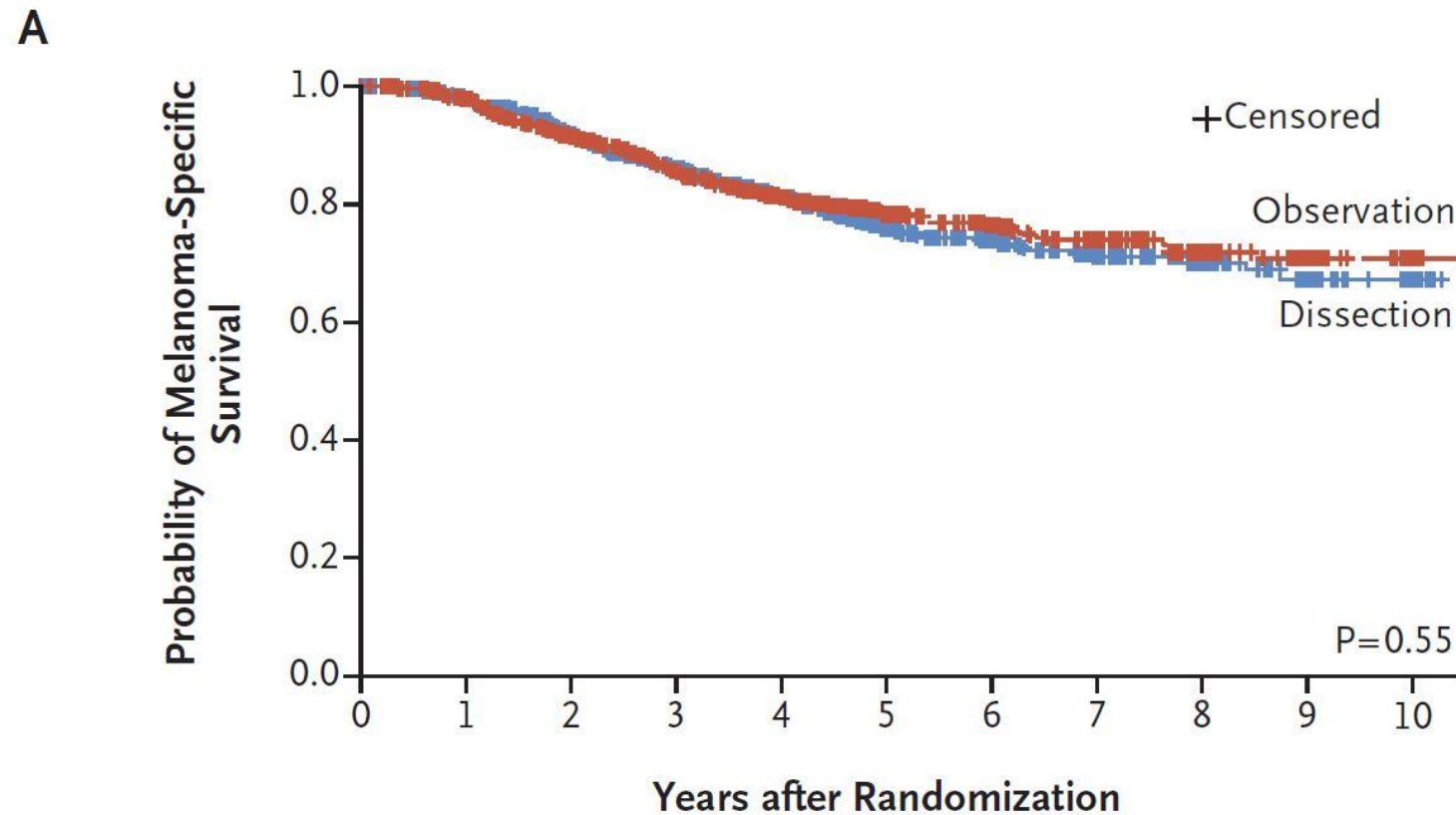
No. at Risk

OBS	117	94	76	68	57	34	0
SNB	173	143	115	101	70	41	0

Completion Dissection or Observation for Sentinel-Node Metastasis in Melanoma; MSLT-2



Completion Dissection or Observation for Sentinel-Node Metastasis in Melanoma; MSLT-2



No. at Risk

Dissection	824	759	654	510	389	275	191	128	83	39	13
Observation	931	856	734	564	425	304	217	151	95	55	13



23 88歳の女性。皮疹を主訴に来院した。3年前から右大腿に皮疹が出現し徐々に拡大してきた。痒みや痛みはない。右大腿伸側に長径約5 cmで一部にびらんを伴う紅斑局面がある。意識は清明。身長164 cm、体重62 kg。脈拍64/分、整。血圧124/84 mmHg。呼吸数24/分。血液所見と血液生化学所見とに異常を認めない。初診時の大腿の写真(別冊No. 4A)と病変部の生検組織のH-E染色標本(別冊No. 4B)とを別に示す。

治療として適切なのはどれか。

- a 光線療法
- b 外科的切除
- c 抗癌化学療法
- d 抗菌薬の投与
- e 抗真菌薬の投与



40 74歳の女性。鼻尖部の皮疹を主訴に来院した。20年前から鼻尖部に皮疹があり、徐々に隆起してきた。顔面の写真(別冊No. 4)を別に示す。皮疹から生検した病理診断の結果は有棘細胞癌であった。

最も考えられる病因はどれか。

- a 飲 酒
- b 肥 満
- c 紫外線
- d アスベスト
- e EBウイルス



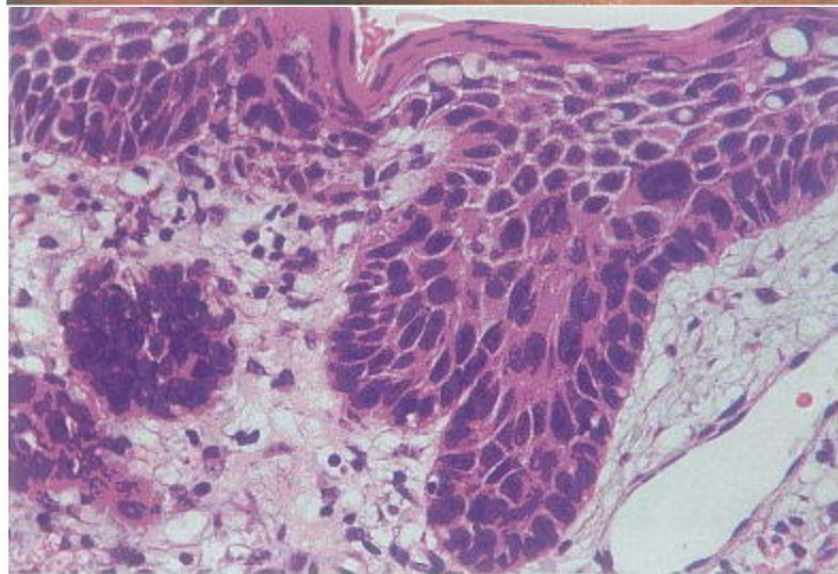
ボーエン病



- ・中高年の体幹四肢に好発する。
- ・境界明瞭な扁平隆起性の鱗屑を付着した局面
- ・軟膏にて軽快しない
- ・確定診断には皮膚生検を行う
- ・治療は手術が基本
- ・手術困難例では放射線治療や抗がん剤の外用
- ・海外ではPDT(光線力学療法)



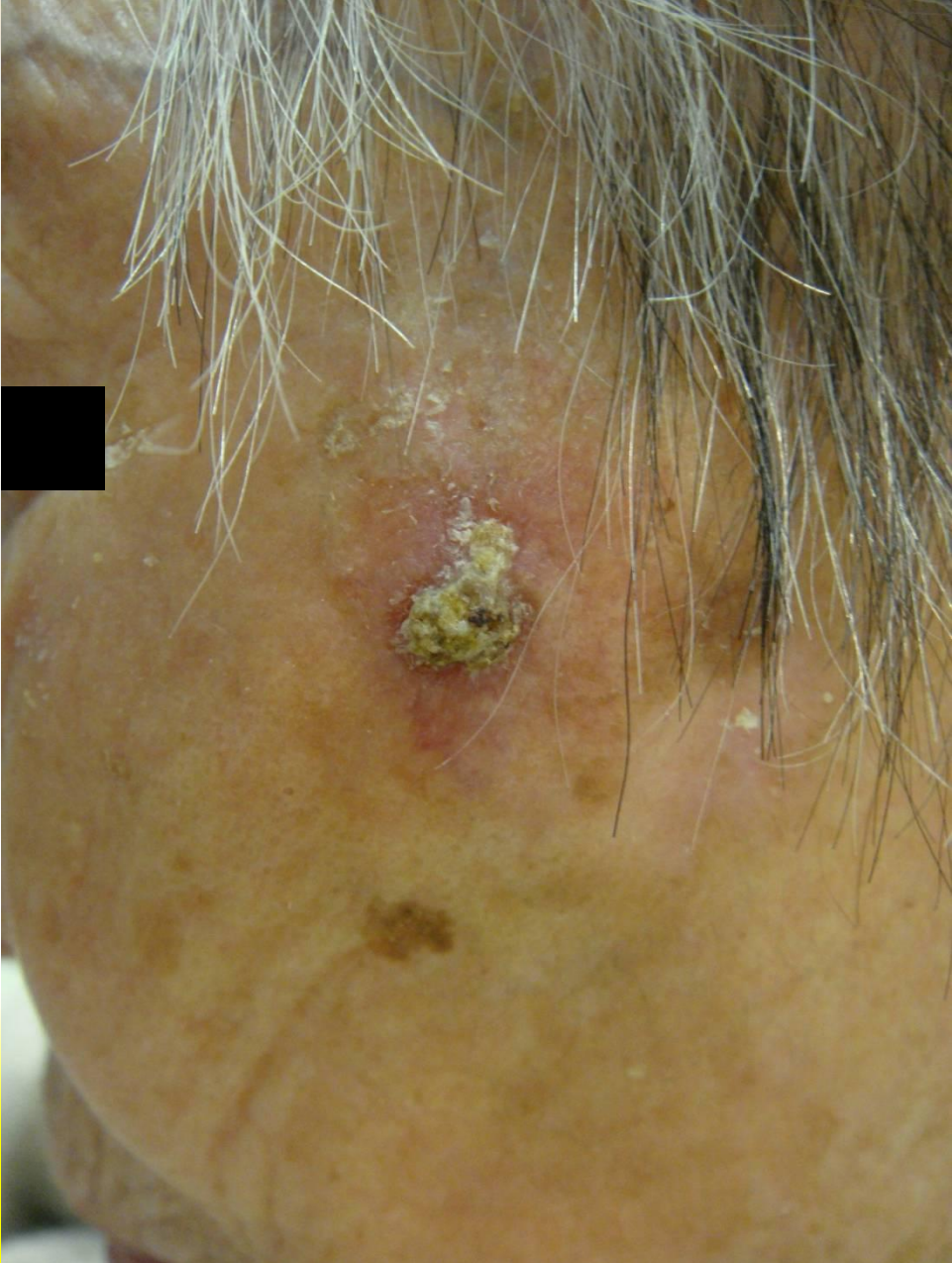
71歳の男性。数年前に出現した顔面の紅色皮疹が拡大してきたことを主訴に来院した。
顔面の写真と同部の病理組織H-E染色標本とを別に示す。



- a 切除
- b 凍結療法
- c 温熱療法
- d 放射線療法
- e 紫外線療法

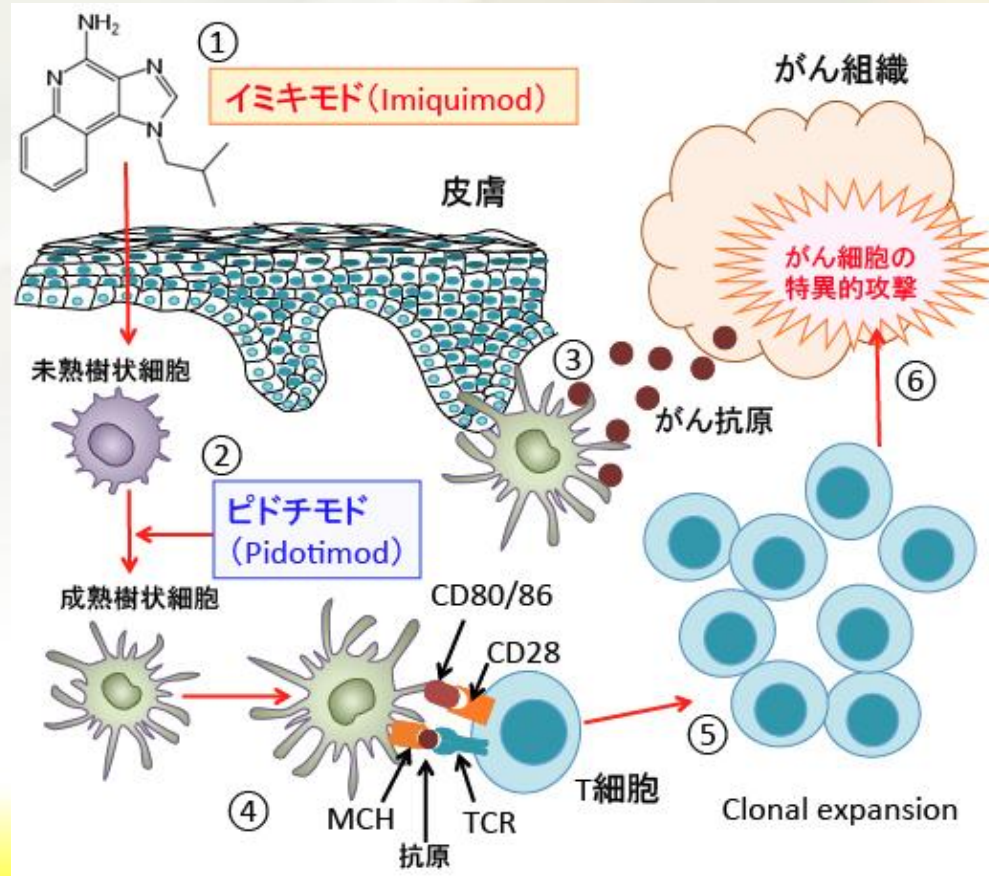
治療法として適切なのはどれか。2つ選べ。

日光角化症



- ・高齢者の顔面、手背などに多い
- ・有棘細胞癌の前駆病変
- ・治療はイミキモドの外
用、液体窒素凝固、手術
療法

イミキモド(ベセルナクリーム®)



光線力学療法 (PDT)

* 日本では保険未承認



68歳、女性。右下肢の潰瘍を主訴に来院した。8歳時に同部位に熱傷を受傷し、瘢痕となっていたが、8ヶ月前より徐々に隆起し、表面が潰瘍化してきた。写真を示す。治療として適切なものはどれか。

- A 外科的切除
- B 紫外線療法
- C 血行再建手術
- D 肉芽形成促進薬外用
- E 腰部交感神経ブロック



有棘細胞癌



- ・中年以降の男性に好発
- ・熱傷、慢性膿皮症、放射線照射、日光角化症などをベースとして出現する
- ・次第に増大し、悪臭を伴う腫瘤や潰瘍を生じる
- ・確定診断は皮膚生検で行う
- ・治療としては外科的切除が基本
- ・転移がある症例や外科的切除が困難な場合は放射線治療や抗がん剤が使用される。



基底細胞癌



基底細胞癌

- ・高齢者に好発
- ・顔面正中が多い
- ・青～黒色
- ・転移を来す可能性は低い
- ・潰瘍化してくることが多い
- ・治療は外科的切除が基本
- ・放射線治療も適応

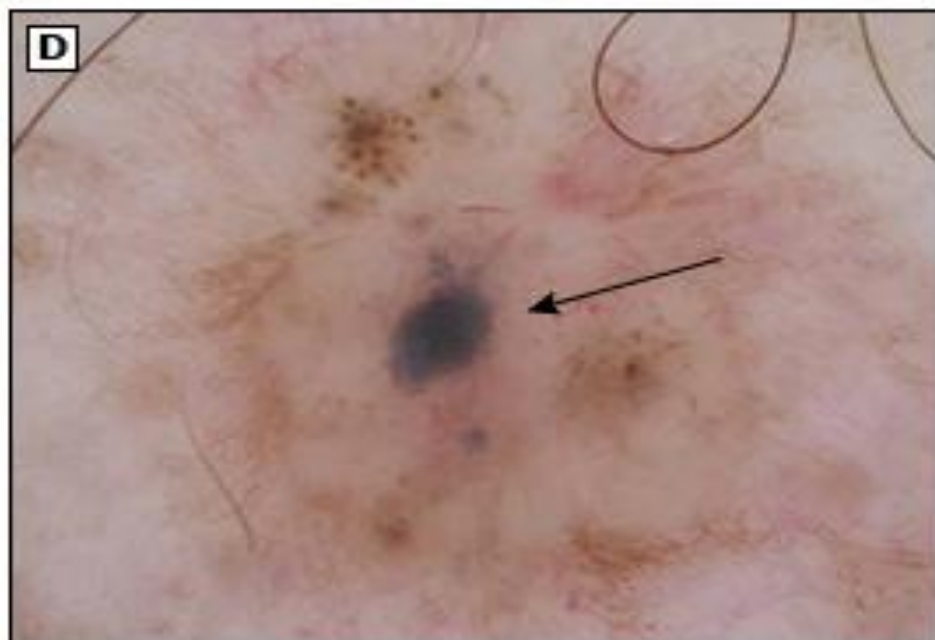
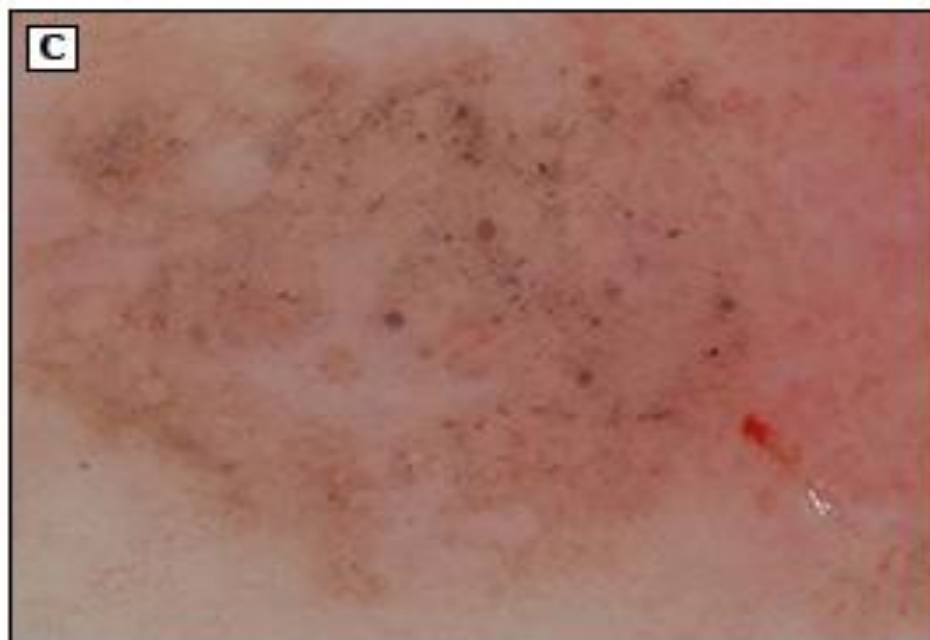
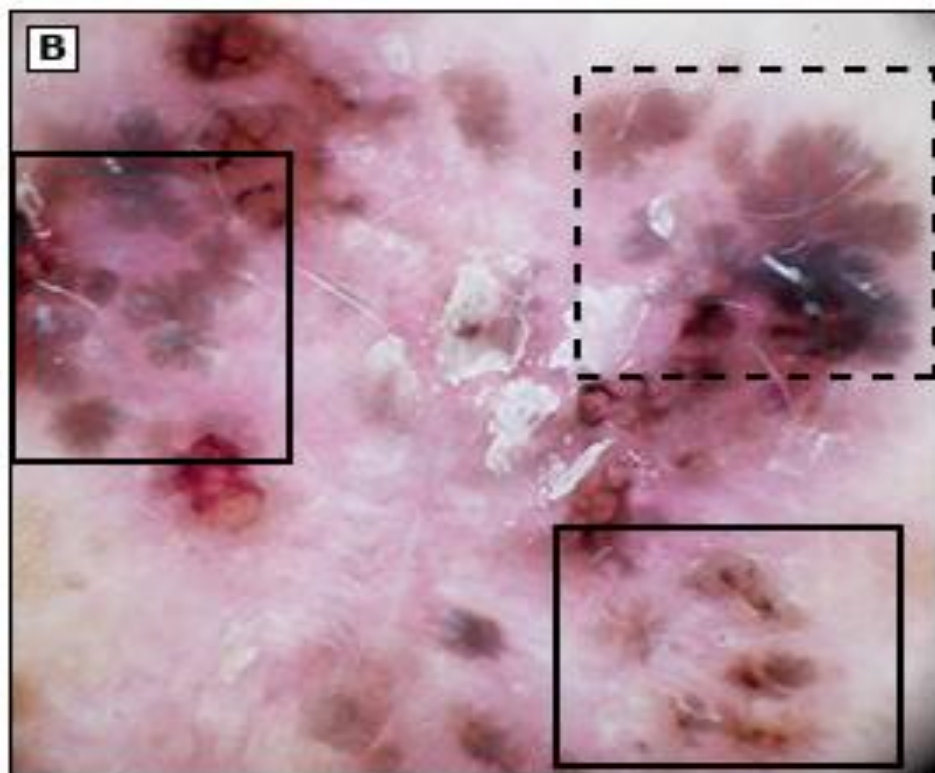
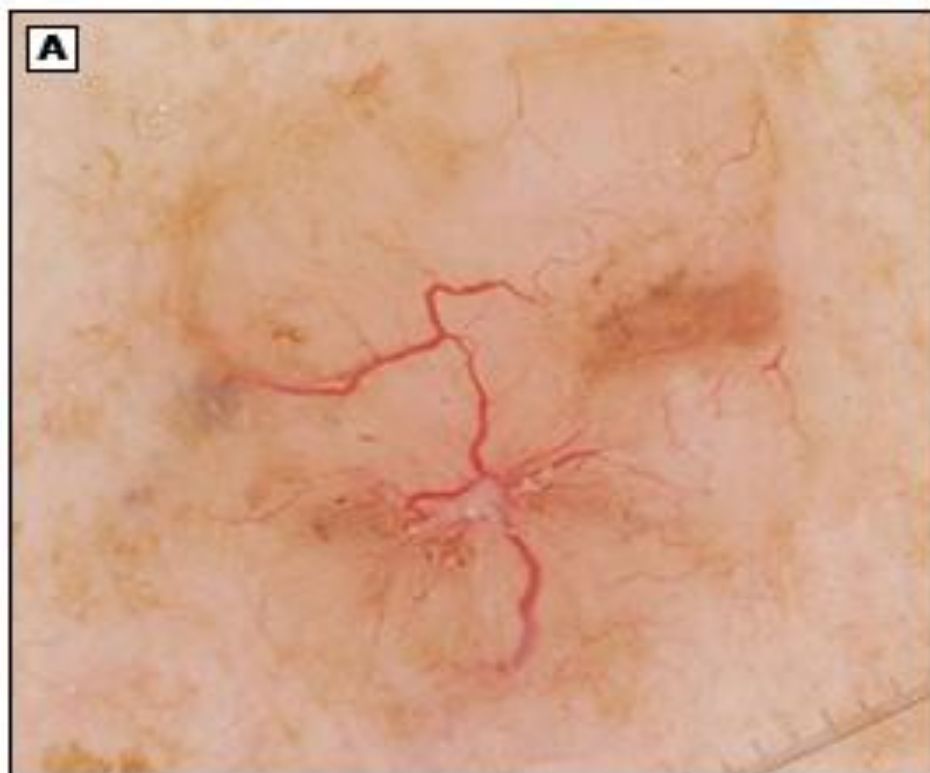




Leaf like area

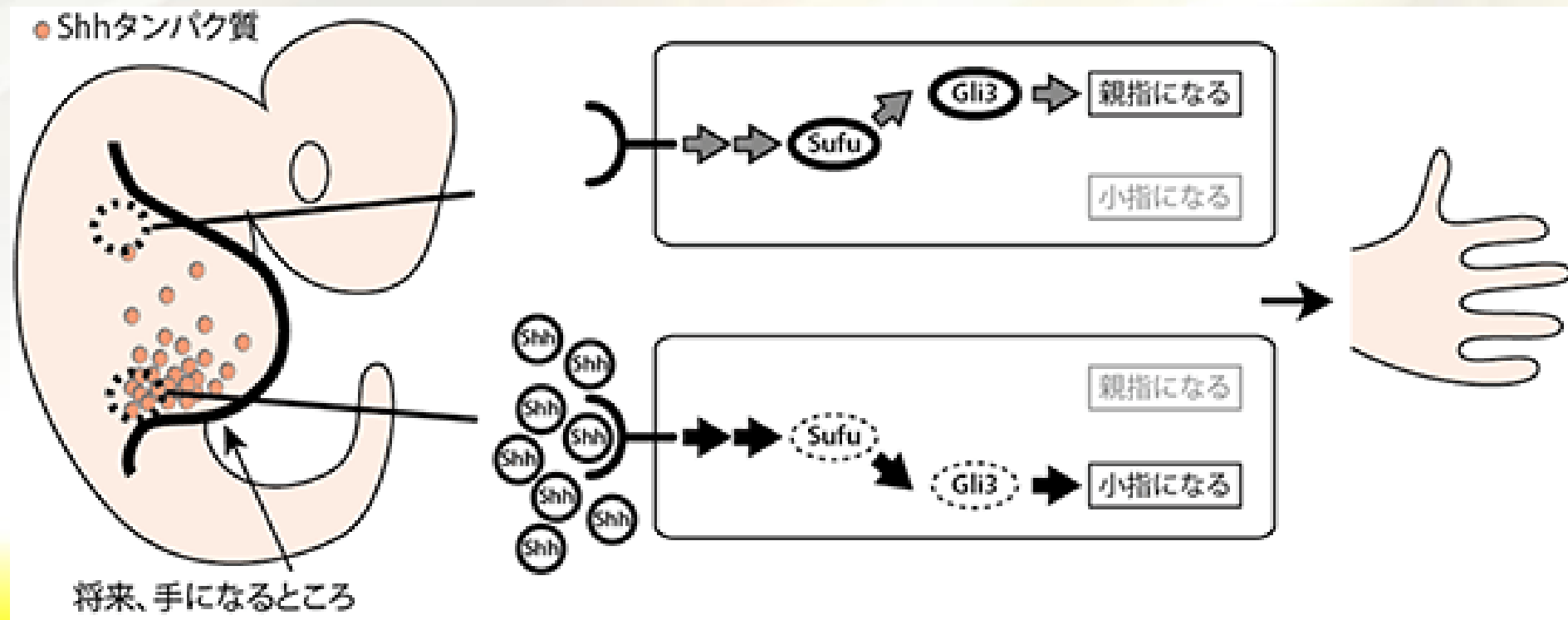
青黒い色





基底細胞癌の新規治療

ヘッジホッグシグナル阻害薬



60 80歳の男性。左側頭部から左頬部の皮疹を主訴に来院した。3か月前に左側頭部に紫紅色斑が出現した。次第に拡大、隆起し、出血するようになった。10年前から心房細動で抗凝固薬を服用中である。皮疹の契機について思い当たることはないという。左側頭部に皮疹を認める。鱗屑は認めない。左頸部リンパ節を触知する。左側頭部の写真(別冊No. 21)を別に示す。

最も考えられるのはどれか。

- a 血管肉腫
- b 有棘細胞癌
- c 老人性紫斑
- d 血管拡張性肉芽腫
- e 抗凝固薬の内服による紫斑



血管肉腫

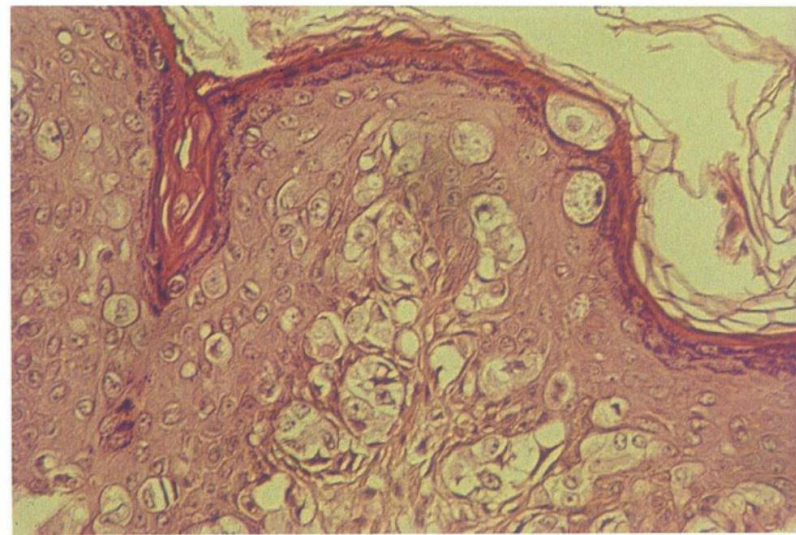


- 高齢者の頭部や顔面に紫斑が出現。
- 急速に増大
- 出血を伴う結節に拡大。
- 血行性に肺に転移しやすい。

8 67歳の男性。陰部の赤い斑を主訴に来院した。3年前から左の陰嚢に痒みを伴う紅斑が出現した。市販の塗り薬で治療していたが、紅斑は次第に拡大してきた。陰嚢の写真(別冊No. 4A)と生検 H-E 染色標本(別冊No. 4B)とを別に示す。

診断はどれか。 -

- a Bowen 病
- b 基底細胞癌
- c 悪性黒色腫
- d 単純性血管腫
- e 乳房外 Paget 病



乳房外Paget病



- ・高齢者に好発
- ・外陰部、腋窩などに好発
- ・確定診断は皮膚生検
- ・病理学的に胞体の明るいPaget細胞を認める。
- ・治療は手術が原則
- ・転移を来すと予後はきわめて不良
(2個以上のリンパ節転移を来した場合、2年生存率0%との報告もある)



紅斑

56歳、女性。
陰部の掻痒感を主訴に
受診
そけい部付近のかゆみ
があり、市販の薬剤を
外用するが、改善なく、
皮疹が徐々に増悪して
きたため受診した。



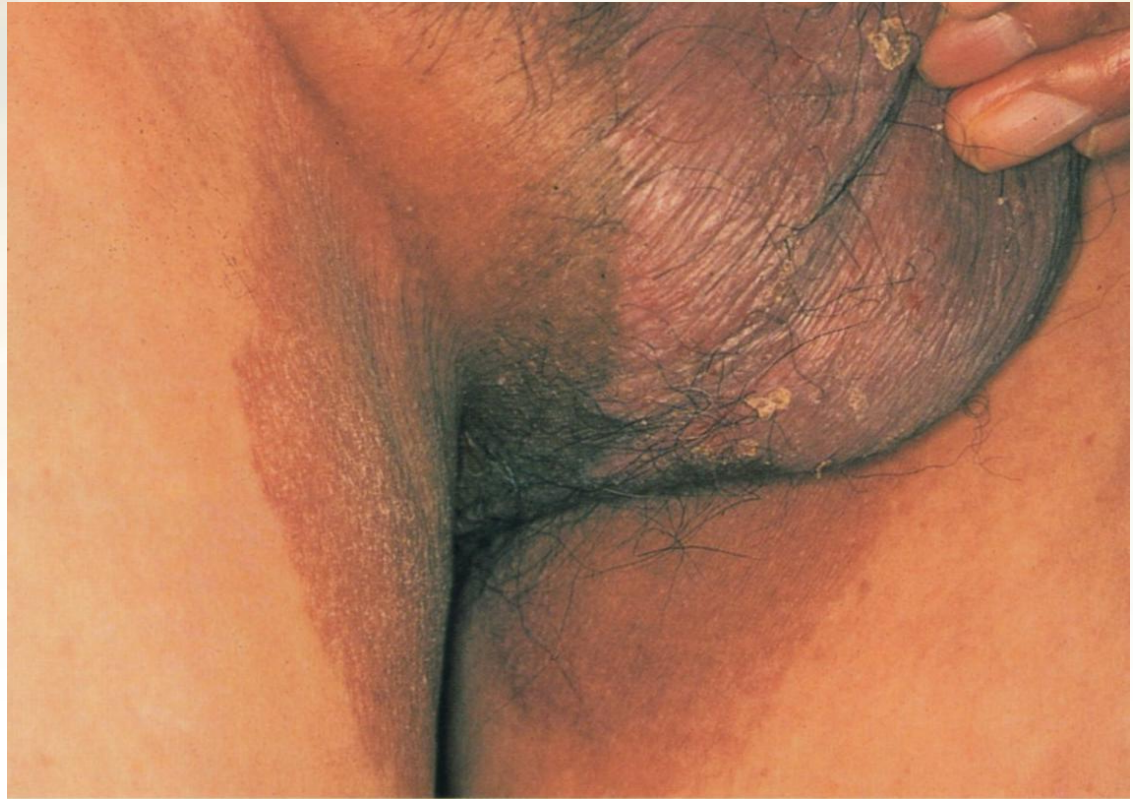
紅斑

78歳、男性
半年ほど前より陰茎に
紅斑が出現、徐々に拡
大傾向にあったため受
診した。



紅斑

83歳、男性
半年ほど前より陰茎に
紅斑が出現、徐々に拡
大傾向にあったため受
診した。
かゆみはない





丘疹

15歳の男性、陰茎に丘疹が出現したため受診
明らかなかゆみや痛みなどはない
性行為は行ったことがない。



丘疹



丘疹



丘疹



丘疹



丘疹



びらん

生後3ヶ月の女児、陰部のびらんを主訴に受診。栄養は完全母乳。兄弟はいない。肉親に同様の症状のものはいない。



びらん



68歳、女性。20年前から区間と氏使途に代償の皮疹が散在性に多発し、次第に堅く触れるようになり、最近一部が隆起してきたため来院した。時々掻痒がある以外には自覚症状はない。背部の写真と病理所見を示す。診断はどれか。

- A 貨幣状湿疹
- B 乾癬
- C 扁平苔癬
- D 皮膚T細胞性リンパ腫
- E スポロトリコーシス

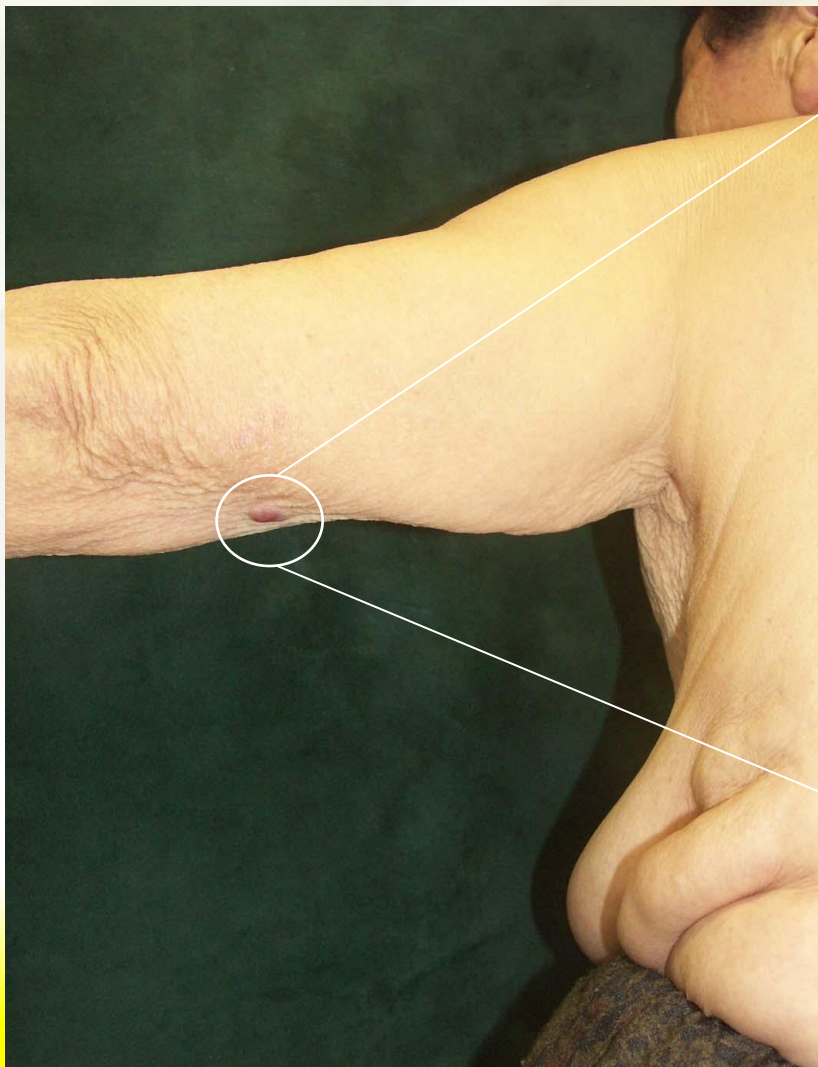


菌状息肉症



- ・中年以降に好発
- ・四肢、体幹に紅斑、局面が散在
- ・数年から数十年かけて徐々に増悪
- ・病理診断でPautrier微小膿瘍
- ・PUVA療法、インターフェロン γ
- ・ベキサロテン
- ・化学療法

メルケル細胞癌



高齢者の顔面・四肢に
硬い紅色丘疹

鼻部基底細胞癌



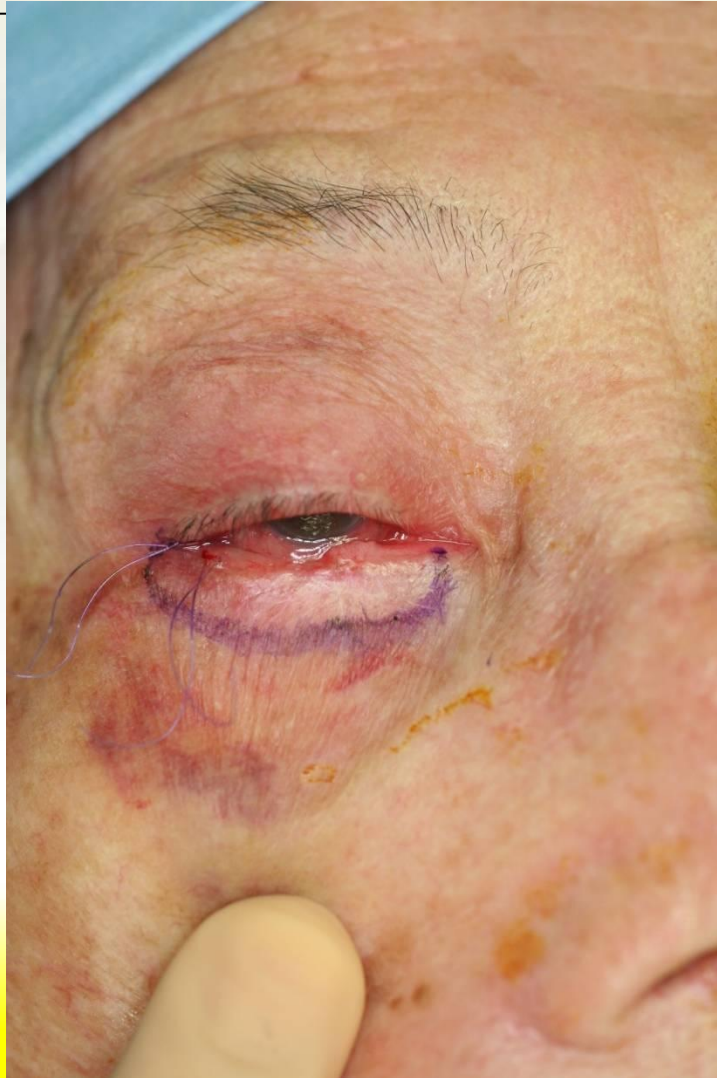
頭部基底細胞癌



下眼瞼基底細胞癌



症例2 下眼瞼基底細胞癌再発



上眼瞼マイボーム腺癌



大腿部熱傷癥痕癌



外耳道基底細胞癌



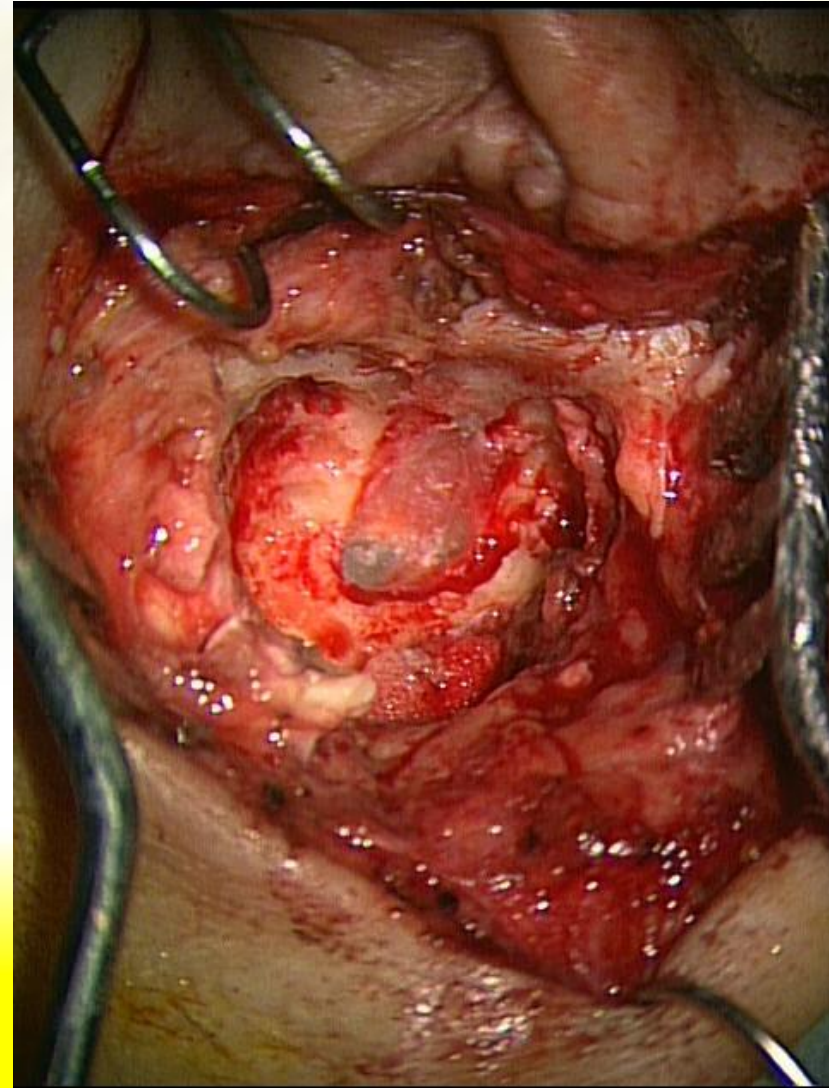
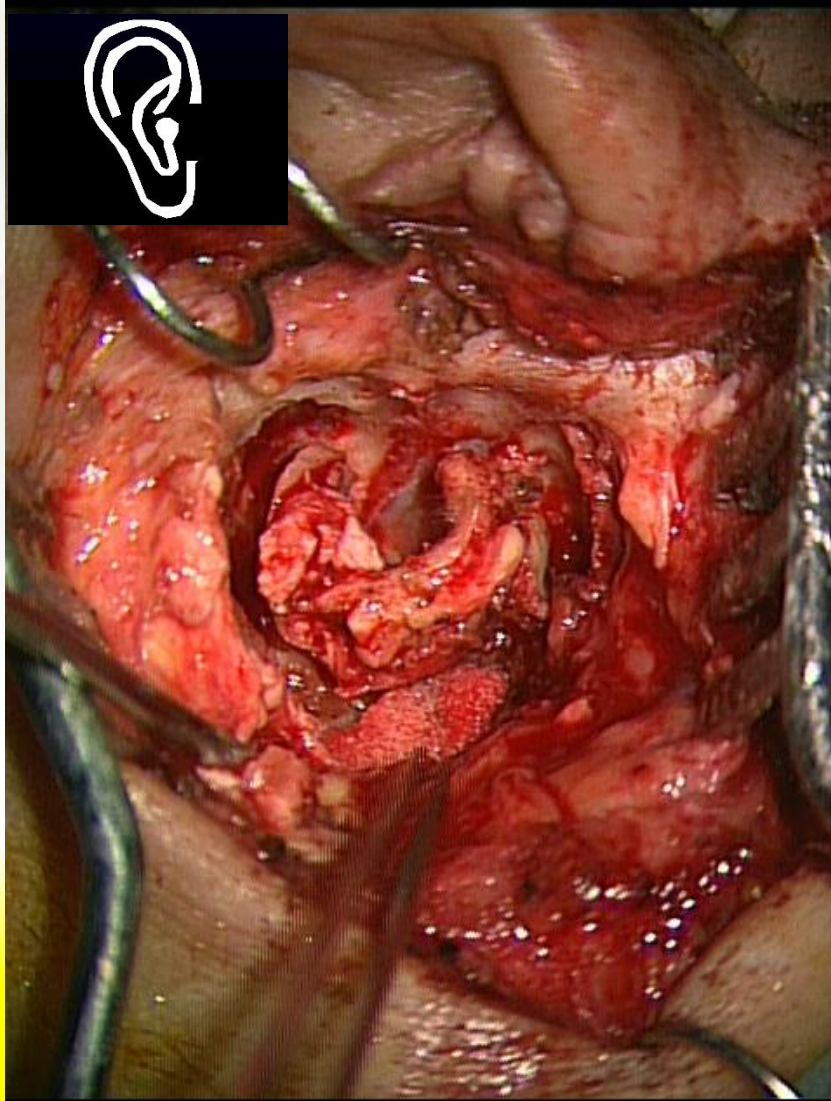
耳甲介部基底細胞癌 (軟骨を切除した症例)



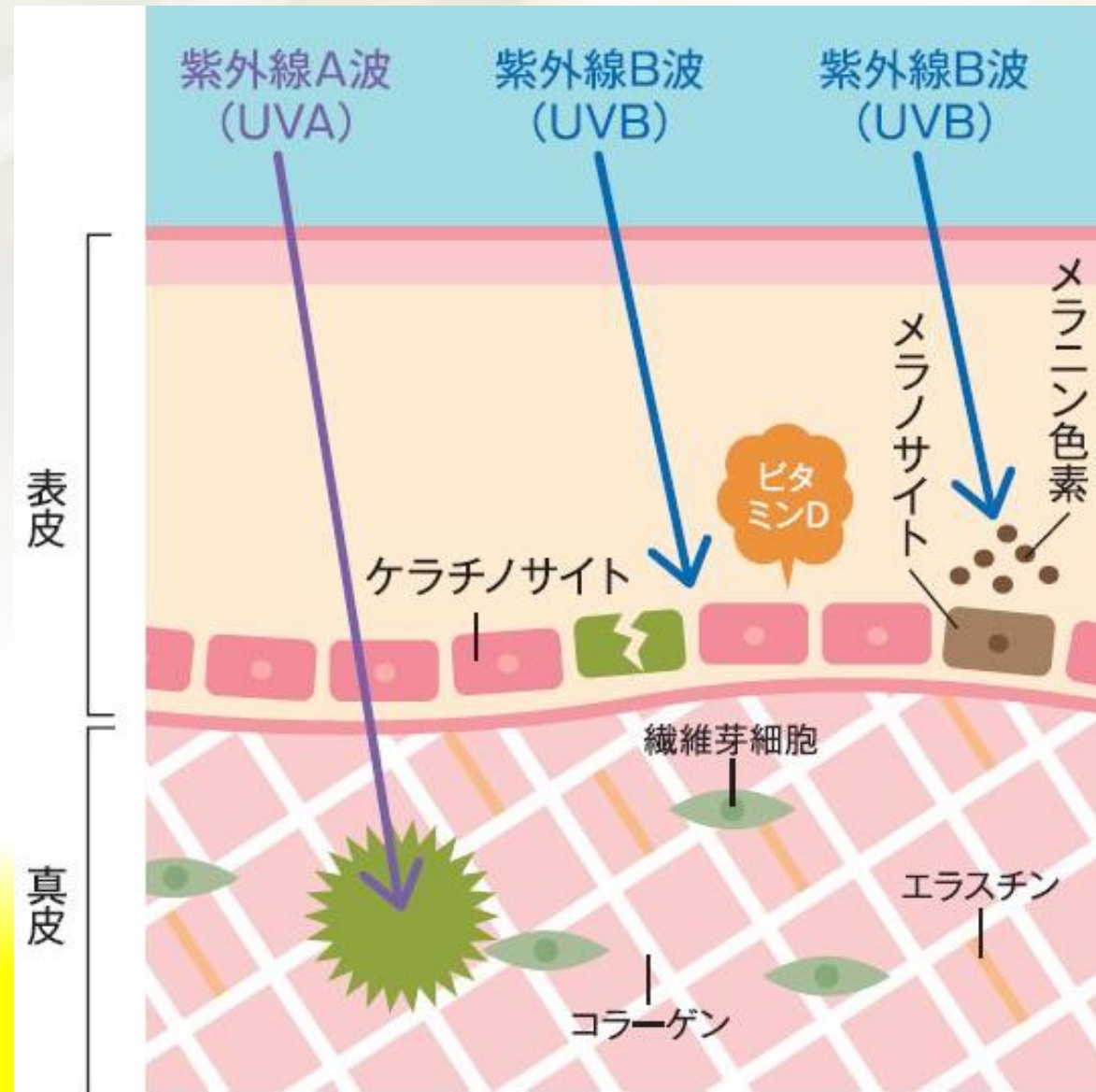
外耳道有棘細胞癌 (外耳道をほぼ全周切除した症例)



外耳道有棘細胞癌 (外耳道をほぼ全周切除した症例)

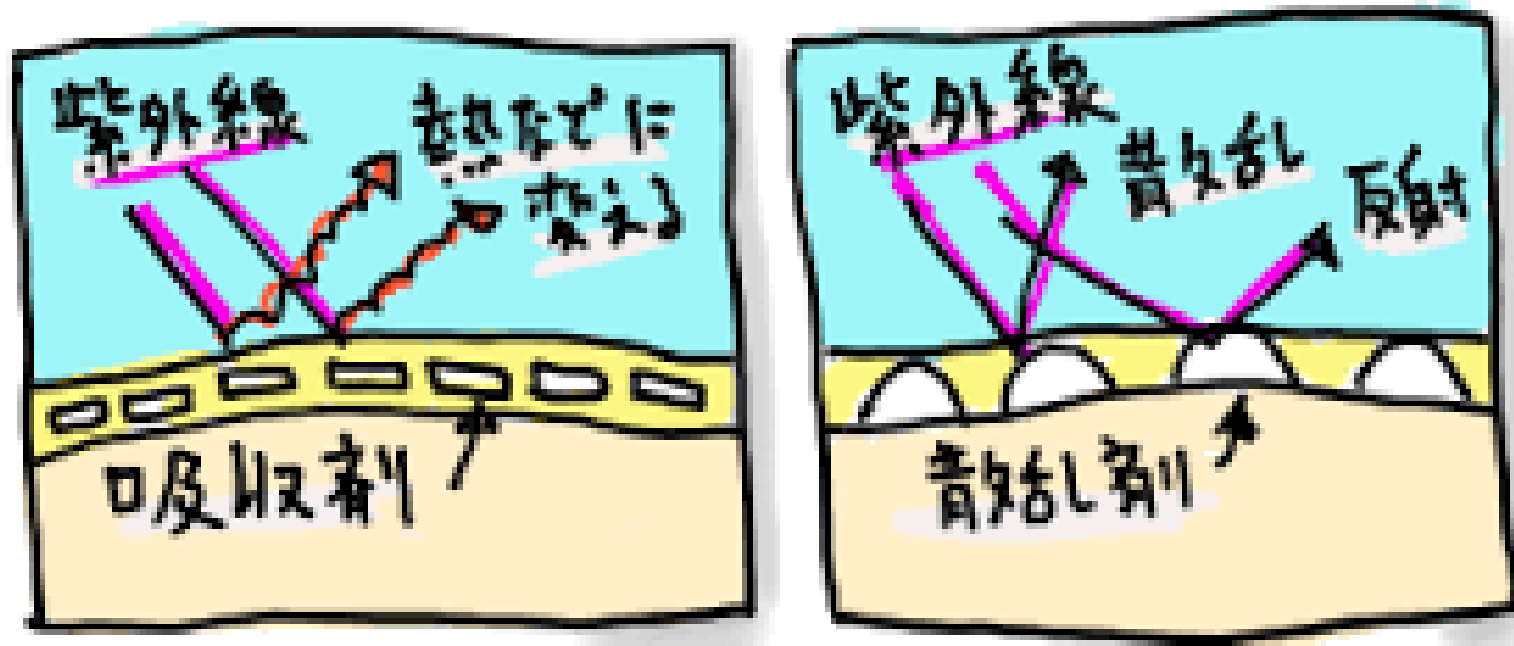


日焼け止めのお話



日焼け止めのお話

日焼け止めの仕組み

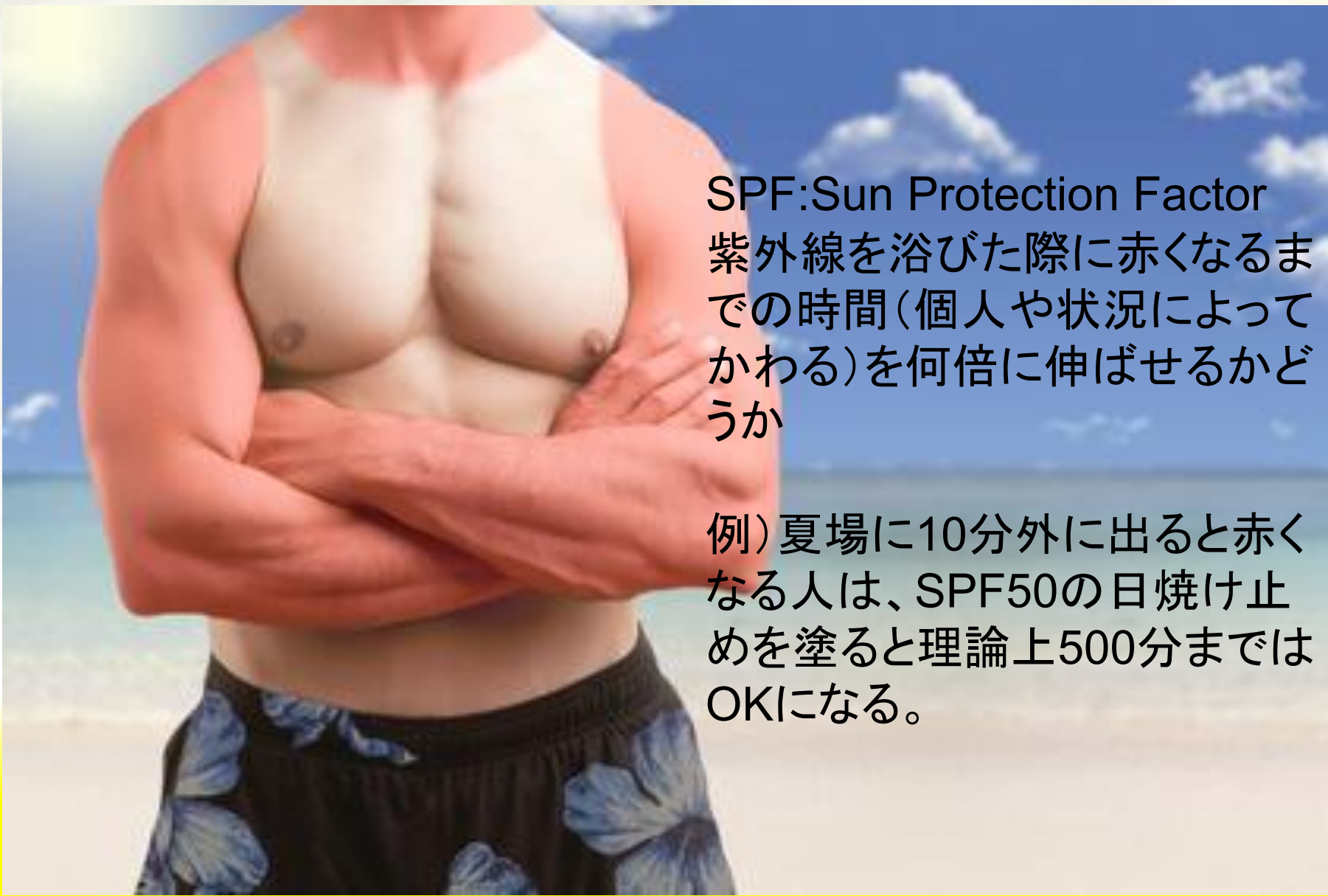


日焼け止めのお話



SPFとPAって何の
ことか知ってます
か？

日焼け止めのお話



SPF:Sun Protection Factor
紫外線を浴びた際に赤くなるまでの時間(個人や状況によってかわる)を何倍に伸ばせるかどうか

例)夏場に10分外に出ると赤くなる人は、SPF50の日焼け止めを塗ると理論上500分まではOKになる。

日焼け止めのお話

PA:Protection Grade of UVA

PA+ 効果がある

PA++ 効果はかなりある

PA+++ 効果が非常にある

PA++++ 効果が極めて高い